



Nur zur dienstlichen Verwendung

Dieser Vermerk verliert seine Gültigkeit mit der Veröffentlichung des Protokolls gemäß § 73 GOBT, spätestens jedoch nach Ablauf der jeweils nachfolgenden Wahlperiode.

Veröffentlichungsdatum: 14.10.2025

Kurzprotokoll der 3. Sitzung

Ausschuss für Gesundheit

Berlin, den 25. Juni 2025, 09:30 Uhr
als Kombination aus Präsenzsitzung
(Paul-Löbe-Haus, Saal E 300) und
Zoom-Meeting.

Vorsitz: Dr. Tanja Machalet, MdB

Tagesordnung

Tagesordnungspunkt 1

Seite 6

Bestimmung der/des stellvertretenden Vorsitzenden

Selbstbefassung S-21(14)9



Nur zur dienstlichen Verwendung

Tagesordnungspunkt 2

Seite 6

Gespräch mit der Bundesministerin für Gesundheit Nina Warken

- a) über die allgemeine Vorhabenplanung sowie die zeitliche Planung folgender Gesetzentwürfe: Pflegekompetenzgesetz, Gesetz zur Pflegeassistenz, Reform der Notfallversorgung und Gesetz zur Einführung eines Primärarztsystems

Selbstbefassung S-21(14)5

- b) über die Umsetzung des Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetzes (KHVVG) und den in den kommenden Jahren erforderlichen Regulierungsbedarf

Selbstbefassung S-21(14)6

- c) über den sogenannten Sudhof-Bericht

Selbstbefassung S-21(14)10

Tagesordnungspunkt 3

Seite 17

Fachgespräch zum jüngsten Schiedsspruch zum Vertrag über die Hebammenhilfe mit dem Schwerpunkt zur Situation der Beleghebammen

Selbstbefassung S-21(14)8

Tagesordnungspunkt 4

Seite 24

Fachgespräch zum aktuellen Gutachten des Sachverständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen und in der Pflege: Preise innovativer Arzneimittel in einem lernenden Gesundheitssystem

Selbstbefassung S-21(14)7



Nur zur dienstlichen Verwendung

Tagesordnungspunkt 5

Seite 30

Unterrichtung durch die Bundesregierung

Federführend:

Ausschuss für Gesundheit

Bericht des GKV-Spitzenverbandes über die Inanspruchnahme und Entwicklung der Versorgung mit Digitalen Gesundheitsanwendungen 2024

BT-Drucksache 21/110

Einführung und Abschluss der Beratung



Nur zur dienstlichen Verwendung

Liste der Sachverständigen

- **Tagesordnungspunkt 3**
Fachgespräch zum jüngsten Schiedsspruch zum Vertrag über die Hebammenhilfe mit dem Schwerpunkt zur Situation der Beleghebammen

Ilona Strache

(1. Vorsitzende des Bundes freiberuflicher Hebammen Deutschlands (BfHD))

Ulrike Geppert-Orthofer

(Präsidentin des Deutschen Hebammenverbands (DHV))

Dr. Christine Bruhn (Vorstandsmitglied des Netzwerks der Geburtshäuser)

Steffen Waiß, Felix Engelhard

(GKV-Spitzenverband)

Prof. Henriette Neumeyer

(stellv. Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG))

- **Tagesordnungspunkt 4**
Fachgespräch zum aktuellen Gutachten des Sachverständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen und in der Pflege: Preise innovativer Arzneimittel in einem lernenden Gesundheitssystem

Prof. Dr. Michael Hallek

(Vorsitzender des Sachverständigenrates)

Prof. Nils Gutacker, PhD

(Mitglied des Sachverständigenrates)

Prof. Dr. Leonie Sundmacher

(Mitglied des Sachverständigenrates)



Nur zur dienstlichen Verwendung

Mitglieder des Ausschusses

Fraktion	Ordentliche Mitglieder	Stellvertretende Mitglieder
CDU/CSU	Beek, Sascha van Borchardt, Simone Hiller, Dr. Matthias Janssen, Anne Müller, Axel Pauls, Dr. Thomas Pilsinger, Dr. Stephan Schmidt, Sebastian Seitz, Nora Streeck, Dr. Hendrik Theiss, Dr. Hans Weiss, Dr. Maria-Lena Zeulner, Emmi	Albani, Stephan Demuth, Ellen Ehm, Lars Grasse, Adrian Knoerig, Axel Ludwig, Dr. Saskia Müller, Sepp Reddig, Pascal Rupprecht, Albert Staffler, Katrin Stegemann, Albert Timmermann-Fechter, Astrid Walch, Siegfried
AfD	Baum, Dr. Christina Bloch, Joachim Dietz, Thomas Ebenberger, Tobias Hess, Nicole Schießl, Carina Sichert, Martin Weiss, Claudia Ziegler, Kay-Uwe	Bessin, Birgit Birghan, Dr. Christoph Bollmann, Gereon Fetsch, Thomas Giersch, Alexis L. Kempf, Martina Möller, Stefan Przygodda, Kerstin Schmidt, Dr. Paul
SPD	Machalet, Dr. Tanja Mieves, Matthias David Moll, Claudia Pantazis, Dr. Christos Schwartz, Stefan Seitzl, Dr. Lina Yüksel, Serdar	Ahmetovic, Adis Dittmar, Sabine Glöckner, Angelika Kersten, Dr. Franziska Peick, Jens Schmidt, Dagmar
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	Dahmen, Dr. Janosch Fischer, Simone Heitmann, Linda Kappert-Gonther, Dr. Kirsten Wagner, Johannes	Grau, Dr. Armin Nick, Dr. Ophelia Piechotta, Dr. Paula Rietenberg, Sylvia
Die Linke	Gürpinar, Ates Merendino, Stella Schötz, Evelyn Stange, Julia-Christina	Arndt, Dr. Michael Brückner, Maik Fey, Katrin Gebel, Kathrin



Nur zur dienstlichen Verwendung

Die Anwesenheitslisten liegen dem Originalprotokoll bei.



Nur zur dienstlichen Verwendung

Beginn der Sitzung: 9:30 Uhr

Vor Eintritt in die Tagesordnung

Die **Vorsitzende**, Abg. **Dr. Tanja Machalet** (SPD), führt zur Tagesordnung aus, in der Obleute-Besprechung sei vereinbart worden den Tagesordnungspunkt 5 abzusetzen und auf die Sitzung am 10. September 2025 zu verschieben um dazu ein Fachgespräch zu führen. Sie stellt die Tagesordnung fest.

Tagesordnungspunkt 1

Bestimmung der/des stellvertretenden Vorsitzenden

Selbstbefassung S-21(14)9

Die **Vorsitzende** erklärt, das Vorschlagsrecht liege bei der Fraktion der CDU/CSU und sie bitte um einen Vorschlag.

Abg. **Emmi Zeulner** (CDU/CSU) schlägt Abg. Dr. Stephan Pilsinger vor.

Abg. **Matthias David Mieves** (SPD) beantragt geheime Wahl.

Abg. **Kay-Uwe Ziegler** (AfD) erklärt, die Fraktion der AfD verzichte auf geheime Wahl und akzeptiere den vorgeschlagenen Kandidaten. In der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages (GO-BT) sei keine Wahl vorgesehen.

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion der AfD bei Stimmenthaltung der Fraktion Die Linke, eine geheime Wahl durchzuführen.

Die **Vorsitzende** erläutert, vor dem Sitzungssaal stünden Tischwahlkabinen zur Verfügung. Es könne mit Ja, Nein und Enthaltung abgestimmt werden. Gewählt sei, wer mehr Ja- als Nein-Stimmen auf sich vereinige. Enthaltungen blieben bei der Feststellung der Mehrheit unberücksichtigt.

9:36 Uhr bis 9:43 Uhr geheime Wahl

Die **Vorsitzende** gibt das Wahlergebnis bekannt:

Abgegebene Stimmen: 28

Gültige Stimmen: 28

Ja-Stimmen: 23

Nein-Stimmen: 3

Enthaltungen: 2

Abg. **Dr. Stephan Pilsinger** (CDU/CSU) nimmt die Wahl an.

Die **Vorsitzende** gratuliert Abg. Dr. Stephan Pilsinger zur Wahl.

Tagesordnungspunkt 2

Gespräch mit der Bundesministerin für Gesundheit Nina Warken

a) über die allgemeine Vorhabenplanung sowie die zeitliche Planung folgender Gesetzentwürfe: Pflegekompetenzgesetz, Gesetz zur Pflegeassistenten, Reform der Notfallversorgung und Gesetz zur Einführung eines Primärarztsystems

Selbstbefassung S-21(14)5

b) über die Umsetzung des Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetzes (KHVVG) und den in den kommenden Jahren erforderlichen Regulierungsbedarf

Selbstbefassung S-21(14)6

c) über den sogenannten Sudhof-Bericht

Selbstbefassung S-21(14)10

Die **Vorsitzende** begrüßt die Bundesministerin für Gesundheit.

BMin **Nina Warken** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) betont die Bereitschaft zur engen Zusammenarbeit mit dem Ausschuss, um das deutsche Gesundheitssystem zukunftsfähig zu gestalten. Angesichts der großen Herausforderungen wie der finanziellen Lage, dem demografischen Wandel und dem medizinischen Fortschritt sei Mut zur Veränderung notwendig. Sie sei offen für konstruktive Vorschläge. Ein zentrales Vorhaben sei der Abbau von Bürokratie. Sie spreche sich dafür aus, Dokumentations- und Verwaltungspflichten sowie Kontrolllichten zu verringern und digitale Prozesse zu stärken, um mehr Zeit für die Patientenversorgung zu gewinnen. Hier sehe sie auch die Selbstverwaltung in der Pflicht.

Ein weiterer Schwerpunkt sei die Bekämpfung des Fachkräftemangels. Angesichts des demografischen Wandels sei die Zuwanderung von Fachkräften unerlässlich. Es gelte, die Anerkennungsverfahren für ausländische Fachkräfte zu vereinfachen, wozu noch in diesem Jahr ein entsprechender Gesetzentwurf vorgelegt werde.

Zudem sei es wichtig, die medizinische Versorgung



Nur zur dienstlichen Verwendung

unabhängig vom Wohnort und insbesondere in ländlichen Räumen zu gewährleisten. Der hohen Erwartungshaltung der Bevölkerung müsse entsprochen werden.

Sie kündigt Nachbesserungen zum Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz (KHVVG) an. Hierzu stehe sie bereits in Kontakt mit den Bundesländern. Zur besseren Umsetzung des KHVVG seien unter anderem Anpassungen bei den Leistungsgruppen und Zwischenfristen sowie eine Überarbeitung der Definition von Fachkrankenhäusern vorgesehen. Eine finanzielle Unterstützung sei durch einen Bundeszuschuss von vier Milliarden Euro zur Deckung der Soforttransformationskosten und durch 4 Zahlungen zu je 3,5 Milliarden Euro und 6 Zahlungen zu je 2,5 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen Infrastruktur in den nächsten 10 Jahren geplant, was auch die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) entlasten solle. Zudem wolle sie eine Erweiterung der Ausnahmen und Kooperationsmöglichkeiten zur Sicherung der Grundversorgung in ländlichen Gebieten vornehmen. Sie plane eine Anpassung der Leistungsgruppen, eine Überarbeitung der Vorgaben für Belegärzte sowie zu den Vollzeitäquivalenten und der Anrechenbarkeiten von Ärzten pro Leistungsgruppe.

Auch im Bereich der GKV-Finzen sehe sie dringenden Handlungsbedarf. Die im Koalitionsvertrag vorgesehene Expertenkommission müsse früher als Anfang 2027 Ergebnisse vorlegen, um zeitnah Maßnahmen ergreifen zu können.

Sie betont den dringenden Handlungsbedarf bei der Finanzierung der Sozialen Pflegeversicherung (SPV). Eine im Koalitionsvertrag vorgesehene Bund-Länder-Arbeitsgruppe werde die Grundlagen für eine umfassende Pflegereform erarbeiten. Diese Arbeitsgruppe werde ihre Arbeit am 7. Juli 2025 aufnehmen und plane, bis Ende des Jahres erste Ergebnisse vorzulegen. Für den Bereich der Pflege sehe sie das gemeinsam mit dem Bundesfamilienministerium erarbeitete Pflegefachassistentengesetz vor, die bisher länderspezifischen Ausbildungen in einer bundesweit einheitlichen, 18-monatigen generalistischen Ausbildung zusammenzuführen. Zum ersten Mal sollen alle Auszubildenden eine Vergütung erhalten, um die Attraktivität der Ausbildung zu steigern. Zudem sollen Personen mit einer anderen abgeschlossenen Berufsausbildung Zugang zur Pflegefachassistentenausbildung erhalten. Der Gesetzesentwurf, der auch eine Übergangsregelung für die

Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse beinhalte, solle im August im Kabinett beschlossen werden, um einen Ausbildungsbeginn im Jahr 2027 zu ermöglichen.

Außerdem solle noch vor der Sommerpause das Pflegekompetenzgesetz vorgelegt werden. Ziel sei es, die Rahmenbedingungen für Pflegekräfte zu verbessern, indem sie mehr Eigenverantwortung erhielten und ihre Kompetenzen, etwa in der Wundversorgung, im Diabetes- oder Demenzmanagement, stärker einbringen könnten. Durch die Entlastung von Bürokratie solle der Beruf attraktiver werden. Des Weiteren kündigt sie eine Reform der Notfallversorgung an, die auch den Rettungsdienst umfassen werde. Sie betont die Notwendigkeit einer funktionierenden und wirtschaftlichen Notfall- und Akutversorgung mit bundesweit gleichwertigen Standards. Der Reformvorschlag aus der letzten Legislaturperiode solle als Grundlage dienen und um den Bereich des Rettungsdienstes erweitert werden, um einheitliche Rahmenbedingungen für Leistungserbringer und die GKV zu schaffen. Gespräche mit den Ländern sollten schnellstmöglich aufgenommen werden, um das Gesetz noch über den Sommer anzupassen und dann vorlegen zu können. Ferner solle ein Primärärztsystem eingeführt werden. Dieses solle bei Beibehaltung der freien Arztwahl eine zielgerichtete und bedarfsgerechte Versorgung gewährleisten. Durch einen strukturierten Zugang zu Fachärzten mit Termingarantie solle der Terminfrust bei den Bürgerinnen und Bürgern reduziert und sollten die Fachärzte entlastet werden. Sie weist darauf hin, dass die Umsetzung einen durchdachten Transformationsprozess und einen längeren Vorlauf erfordere. Die ersten Gespräche dazu hätten bereits begonnen.

Abschließend hebt sie die Frauengesundheit als ein zentrales Anliegen hervor, das bisher zu wenig Beachtung gefunden habe. Sie betont, dass geschlechtsspezifische Unterschiede in Forschung, Prävention und Versorgung stärker berücksichtigt werden müssten, um die Lebensrealität aller Menschen abzubilden. In diesem Zusammenhang verweist sie auf den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetzes, das dem besonderen Schutz von Frauen, Kindern und Jugendlichen diene und am 2. Juli im Kabinett behandelt werden solle.

Abg. **Martin Sichert** (AfD) erkundigt sich, ob es zulässig sei, dass das gesamte BGM online der nicht-öffentlichen Sitzung folge.



Nur zur dienstlichen Verwendung

Die **Vorsitzende** entgegnet, es handele sich um die Bundesregierung, was zulässig sei.

Abg. **Simone Borchardt** (CDU/CSU) erkundigt sich nach dem aktuellen Stand der Haushaltsberatungen der Bundesregierung für das laufende und das kommende Jahr. Sie fragt zudem, welche Rolle das Sondervermögen für den Bereich Gesundheit und Pflege in diesen Beratungen spielt.

BMin **Nina Warken** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) antwortet, das Kabinett habe am Vortag den Haushalt beraten. Um die Zeit bis zu den geplanten Reformen zu überbrücken, werde es eine finanzielle Unterstützung aus dem Haushalt geben. Für die GKV seien Darlehen in Höhe von jeweils 2,3 Milliarden Euro für 2025 und 2026 vorgesehen, zudem werde ein offenes Darlehen in Höhe von 1 Milliarde Euro gestundet. Sie hofft, dadurch ohne Beitragserhöhungen auszukommen, schätzt jedoch, dass ab 2027 mit Beitragserhöhungen zu rechnen sei. Für die SPV seien für 2025 und 2026 Darlehen von 0,5 Milliarden beziehungsweise 1,5 Milliarden Euro geplant, wobei Beitragserhöhungen noch nicht gänzlich abgewendet seien. Zum Sondervermögen führt sie aus, dass der Gesundheitsbereich gut abschneide. Die Krankenhäuser erhielten 4 Milliarden Euro als Soforthilfe und zusätzlich 4 Zahlungen zu je 3,5 Milliarden Euro und 6 Zahlungen zu je 2,5 Milliarden Euro aus dem Soforttransformationsfonds. Zudem werde das Geld für die Digitalisierung des Rettungsdienstes, für Forschung und Entwicklung, den Aufbau einer vernetzten Gesundheitsdateninfrastruktur und KI-Allabore genutzt. Der Gesundheitsbereich erhalte demnach rund 10 Prozent des Sondervermögens von 300 Milliarden Euro, die dem Bund zustehen. Auch bei den Ausnahmen von bestimmten Bereichen von der Schuldenbremse profitiere der Gesundheitsbereich etwa bei der Cybersicherheit. Sie betont, dass dies alles unter dem Vorbehalt der parlamentarischen Beratungen stehe und bekräftigt, dass die finanzielle Situation von GKV und SPV weiterhin schwierig sei.

Abg. **Simone Borchardt** (CDU/CSU) fragt ergänzend, welche Prüfverfahren und Maßnahmen das BMG anstoße, um einen Bürokratieabbau im Gesundheitswesen voranzutreiben.

BMin **Nina Warken** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) antwortet, dass Handlungsbedarf zur Verringerung der Bürokratie in verschiedenen

Bereichen, darunter in Apotheken, Krankenhäusern und der ambulanten Versorgung, bestehe. Im BMG seien bereits zahlreiche Felder identifiziert worden. Zudem sammle und sichte das BMG Vorschläge von der Ärzteschaft, dem Landkreistag und der Krankenhausgesellschaft. Sie selbst führe Gespräche mit den Beteiligten. Geplant sei, ein Gesetz auf den Weg zu bringen, das Dokumentations- und Berichtspflichten sowie die Kontrollen reduziere. Dies solle während der Sommerpause angegangen werden, wobei auch geprüft werde, welche Vorschläge schnell umgesetzt werden könnten.

Abg. **Martin Sichert** (AfD) erkundigt sich nach den zugesagten Investitionen in die WHO und den Bereich Global Health, die die Ministerin bei einem Treffen mit Bill Gates besprochen habe. Er fragt, um welche Summen es sich dabei handle und wo diese Gelder eingespart werden sollten.

BMin **Nina Warken** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) entgegnet, dass sie Bill Gates kein Geld versprochen habe. Vielmehr gehe es um die Finanzierung der WHO, die sich seit dem Rückzug der USA in einer schwierigen Lage befinde. Deutschland stehe weiterhin zu einer starken WHO und unterstütze deren Arbeit in den Bereichen Krisenvorsorge, Krisenprävention und Datenauswertung. Sie habe in Genf eine zusätzliche Unterstützung von 10 Millionen Euro übergeben. Deutschland werde seine Pflichtbeiträge für die WHO weiterhin leisten, gleichzeitig aber die freiwilligen Beiträge reduzieren. Mit Bill Gates habe sie über die weitere Unterstützung des WHO-Hubs in Berlin gesprochen, das im aktuellen Haushalt mit 20 Millionen Euro veranschlagt sei. Ziel des Gesprächs sei es gewesen, Bill Gates für die Förderung dieses Hubs zu gewinnen, was sowohl für Deutschland als auch für die WHO vorteilhaft wäre. Es gehe nicht um zusätzliche Gelder, sondern um die Einhaltung bestehender Finanzierungszusagen.

Abg. **Martin Sichert** (AfD) greift die Ankündigungen der Ministerin zum Bürokratieabbau und zur Sicherstellung der Versorgung im ländlichen Raum auf. Er fragt, wie die Einführung eines Primärarztsystems verhindern solle, dass die zusätzlichen Aufgaben für Hausärzte, insbesondere in ländlichen Gebieten mit Hausärztemangel, zu einer Verschlechterung der Versorgung führten. Als Beispiel nennt er den Fall eines Knochenbruchs, bei dem Patienten dann nicht mehr direkt zum Orthopäden gehen könnten, sondern zuerst eine Überweisung



Nur zur dienstlichen Verwendung

vom Hausarzt bräuchten.

BMin **Nina Warken** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) entgegnet, dass man sich der prekären Versorgungslage bei Hausärzten bewusst sei und die Einführung eines Primärarztsystems keinen zusätzlichen Flaschenhals erzeugen solle. Um dem entgegenzuwirken, werde das System auf mehrere Säulen gestellt, darunter die Nutzung der Rufnummer 116 117 und der Telemedizin. Zudem solle die Bürokratie für Hausärzte reduziert werden, um ihnen mehr Zeit und Freiräume für ihre Patienten zu verschaffen. Insgesamt solle die Niederlassung als Hausarzt für junge Mediziner attraktiver gemacht werden.

Abg. **Martin Sichert** (AfD) fragt, welche Vergütungsregelungen für Hausärzte im Rahmen des Primärarztsystems geplant seien, insbesondere für die Überweisungen an Fachärzte.

BMin **Nina Warken** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) antwortet, dass es noch keine konkreten Pläne für Vergütungsregelungen gebe. Sie betont, dass viele Fragen noch zu klären seien, wie zum Beispiel die Ausnahmen von der Überweisungspflicht oder die Konsequenzen, wenn Patienten ohne Überweisung direkt zum Facharzt gingen. Dies könne durch ein Anreizsystem oder eine Gebühr geregelt werden. Das Konzept werde derzeit noch erarbeitet.

Abg. **Dr. Christos Pantazis** (SPD) bedankt sich bei der Ministerin für ihre Ausführungen und betont das Interesse seiner Fraktion an einer engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit. Er merkt an, dass die Resonanz auf das im Koalitionsvertrag vereinbarte Primärarztsystem überwiegend positiv sei und die Erfahrungen anderer Länder ermutigten. Er fragt, welche Voraussetzungen in Bezug auf qualifiziertes Personal, Informationsflüsse, Digitalisierung, Abrechnungsregelungen und Organisationsstrukturen erfüllt sein müssten, damit das System auch in Deutschland erfolgreich sein könne, und wie lange es dauere, bis diese Voraussetzungen gegeben seien.

BMin **Nina Warken** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) erwidert, dass sie den Wunsch nach einer schnellen Umsetzung teile, aber auch die Bedenken bezüglich der Personalsituation wahrgenommen habe. Sie betont die Notwendigkeit, die Kompetenzen nichtärztlicher Gesundheitsberufe besser einzubeziehen, um Ärzte zu

entlasten. Zudem sei eine stärkere Digitalisierung erforderlich, beispielsweise bei der Terminvermittlung und der Ersteinschätzung. Die vielen offenen Fragen müssten nun angegangen werden. Eine Gesetzgebung sei in diesem Jahr jedoch nicht mehr zu erwarten, es würden aber bereits Vorarbeiten geleistet.

Abg. **Dr. Christos Pantazis** (SPD) hebt hervor, dass eine Reform der Notfallversorgung und des Rettungsdienstes oberste Priorität habe. Er fragt, wann das Vorhaben angegangen werde und wie die Länder, die der Rettungsdienstreform bisher kritisch gegenüberstünden, eingebunden würden.

BMin **Nina Warken** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) antwortet, dass sie bereits Gespräche mit Vertretern der Länder und Kommunen geführt habe und deren Befürchtungen kenne, dass ihnen durch die Reform Kompetenzen entzogen würden. Sie betont, dass dies nicht die Absicht sei, es aber notwendig sei, Standards und Qualitätsansprüche festzulegen, insbesondere bei der Abrechnung. Abrechnungsprobleme bei dem Titel „Krankentransport“ und bei Fehlfahrten müssten gelöst werden. Die Gespräche seien nicht einfach. Man werde an dem bereits vorliegenden Entwurf der Notfallreform ansetzen und die offenen Fragen klären. Kritik habe es im parlamentarischen Verfahren vor allem an einem Änderungsantrag gegeben, insbesondere an dem Gremium, das Qualitätsstandards festlege. Sie plant, diese Punkte möglichst in der Sommerpause zu klären und den Gesetzentwurf im Herbst vorzulegen.

Abg. **Dr. Janosch Dahmen** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) äußert sich erfreut, dass die wichtigen Vorhaben zügig umgesetzt würden, da sie nicht im 70-Tage-Programm der Bundesregierung enthalten gewesen seien. Mit Blick auf die Dringlichkeit verweist er auf die kürzlich veröffentlichten KV-45-Zahlen, wonach die Ausgaben für den Rettungsdienst im ersten Quartal dieses Jahres um fast 12 Prozent gestiegen seien. Er fragt, wie viel Zeit bleibe, um eine Reform umzusetzen, die nach Schätzungen mindestens 3 Milliarden Euro pro Jahr einsparen könne, und wann die Notfall- und Rettungsdienstreform in Kraft treten solle.

BMin **Nina Warken** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) stimmt der Dringlichkeit der Reform zu und betont, dass sie auf die Einsparungen nicht verzichten könne. Sie räumt jedoch ein, dass



Nur zur dienstlichen Verwendung

es unterschiedliche Meinungen zur Geschwindigkeit der Umsetzung gebe. Sie bekräftigt, dass der Bund in den Bereichen, in denen er zuständig ist, Rahmenbedingungen vorgeben und die Abrechnungsmodalitäten neu regeln müsse. Die Gesetzgebung sei für den Herbst geplant, mit dem Ziel, sie so schnell wie möglich in Kraft treten zu lassen. Sie bittet um Unterstützung bei Gesprächen mit den beteiligten Akteuren, um Bedenken auszuräumen, insbesondere im Hinblick auf den Änderungsantrag und das darin vorgesehene Gremium.

Abg. **Dr. Janosch Dahmen** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) sichert die Unterstützung seiner Fraktion zu. Er weist darauf hin, dass sowohl die demokratischen Fraktionen als auch die Fachverbände die Ausschussanhörung zu dem Änderungsantrag voll unterstützt hätten. Er fragt, da die Zuständigkeit für die Notfall- und Rettungsdienstreformen und die Gebührenordnung der Ärzte (GOÄ) im gleichen Referat liege, ob die Ministerin plane, Ressourcen und Zuständigkeiten zu ändern, um die Geschwindigkeit beider Reformen zu erhöhen.

BMin **Nina Warken** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) erklärt, sie sei froh über die Eini-gung zur GOÄ, auch wenn es einige Zeit gedauert habe, bis die Unterlagen im BMG eingegangen seien. Sie versichert, dass die zuständige Abteilung die Herausforderungen bewältigen könne, da bei der Notfall- und Rettungsdienstreform bereits viel Vorarbeit geleistet worden sei. Sie gesteht zu, dass es sich um keine einfachen Herausforderungen handele, betont aber, dass das BMG es gewohnt sei, unter Hochdruck zu arbeiten.

Abg. **Dr. Janosch Dahmen** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) weist auf das Thema der seelischen Gesundheit hin, das bisher in der Vorhabenplanung der Ministerin keine Rolle gespielt habe. Er ermutigt sie, konkrete Vorarbeiten aus der vergangenen Legisla-tur, wie das Suizidpräventionsgesetz, wieder aufzugreifen und dieses wichtige Thema nicht aus dem Blick zu verlieren.

BMin **Nina Warken** (Bundesministerium für Ge-sundheit (BMG)) bestätigt die Bedeutung der Sui-zidprävention und begrüßt die diesbezüglichen Zu-sammenarbeiten im parlamentarischen Raum. Auch wenn das Thema nicht zu den ersten Vorha-ben bis zur Sommerpause zähle, sei es im Blick.

Abg. **Julia-Christina Stange** (Die Linke) begrüßt den direkten Austausch und die Aussage der

Ministerin, dass Frauengesundheit kein Ni-schenthema sei. Sie fragt, wann Individuelle Ge-sundheitsleistungen wieder von den Krankenkas-sen übernommen würden, um eine gute präventive Versorgung unabhängig vom Geldbeutel zu ermög-lichen.

BMin **Nina Warken** (Bundesministerium für Ge-sundheit (BMG)) antwortet, dass es eine Nutzenbe-wertung durch den Gemeinsamen Bundesaus-schuss (G-BA) gebe, nach der sich die Übernahme von Leistungen in den Regelkatalog richte.

Abg. **Julia-Christina Stange** (Die Linke) spricht die finanzielle Situation der Krankenhäuser an und fragt, ob es bei den geplanten 10 Prozent des Son-dervermögens für den Gesundheitsbereich bleibe, oder ob im Zuge der Strukturreformen und der Sa-nierung der Krankenhäuser mehr Mittel aus dem Sondervermögen beansprucht würden.

BMin **Nina Warken** (Bundesministerium für Ge-sundheit (BMG)) fragt, ob gemeint sei, dass zusätz-liche Mittel vor dem Hintergrund der Resilienz der Krankenhäuser, Cybersicherheit und ähnlichem be-ansprucht würden.

Abg. **Julia-Christina Stange** (Die Linke) präzisiert, sie möchte wissen, ob der Fokus der zusätzlichen Mittel auf der Finanzierung einer allgemeinwohl-orientierten Versorgung liege oder ob die Gelder unter dem Deckmantel der Aufrüstung für militäri-sche Zwecke verwendet werden.

BMin **Nina Warken** (Bundesministerium für Ge-sundheit (BMG)) erklärt, dass der Grundansatz da-rin bestehe, eine verlässliche und erreichbare Ver-sorgung für die Bürger vor Ort zu finanzieren. Gleichzeitig müsse auch die Resilienz der Struktu-ren betrachtet werden, insbesondere im Hinblick auf Cybersicherheit. Sie betont, dass es nicht um eine Aufrüstung, sondern um die Sicherung der be-stehenden Strukturen vor Angriffen von außen gehe. Für diese Zwecke gebe es die Möglichkeit, Mittel aus der Bereichsausnahme der Schulden-bremse oder aus dem Sondervermögen zu erhalten, die zum Teil bereits angemeldet seien.

Abg. **Evelyn Schötz** (Die Linke) fragt, warum die 4 Milliarden Euro aus dem Haushaltsbegleitgesetz nach dem Gießkannenprinzip an alle Krankenhäu-ser verteilt würden und nicht gezielt defizitären Häusern zugutekämen. Sie verweist auf den Ge-winn des Helios-Konzerns im letzten Jahr als



Nur zur dienstlichen Verwendung

Beispiel dafür, dass eine pauschale Verteilung der Mittel nicht sinnvoll sei.

BMin **Nina Warken** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) antwortet, dass die 4 Milliarden Euro in zwei Tranchen dieses und nächstes Jahr über einen zwölfmonatigen Rechnungszuschlag ausgekehrt würden. Dies sei bewusst so gewählt worden, damit alle Häuser partizipieren könnten, da sie keine Möglichkeit gehabt hätten, die Transformationskosten selbst zu erwirtschaften.

Abg. **Simone Borchardt** (CDU/CSU) betont die Wichtigkeit der Prävention in einer immer älter werdenden Gesellschaft. Sie bittet zu erläutern, welche Maßnahmen das BMG ergreife, um in diesem Bereich schneller voranzukommen.

BMin **Nina Warken** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) betont, sie halte insbesondere die Förderung von Bewegung für einen wichtigen Aspekt der Gesundheitsförderung. Sie nenne in diesem Zusammenhang etwa einen runden Tisch zur Förderung spezieller Maßnahmen für Kinder und Jugendliche. Auch das Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit und das Präventionsgesetz spielten in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle. Der Fortentwicklungsbedarf werde auch mit Blick auf vulnerable Gruppen geprüft. Weitere Punkte seien die Stärkung der kommunalen Gesundheitsförderung und die Prävention in Betrieben. Der Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst biete auch für die Prävention eine finanzielle Unterstützung. In der aktuellen Finanzlage werde es schwieriger, solche Maßnahmen fortzuführen. Die Diskussion um das Gesundes-Herz-Gesetz im letzten Jahr zeige, dass hier ein neuer Ansatz gefunden werden müsse.

Abg. **Thomas Dietz** (AfD) fragt zur Krankenhausreform. Er befürchtet, dass die Einteilung in 65 Leistungsgruppen dazu führe, dass viele Krankenhäuser im ländlichen Raum die Mindestanforderungen nicht erfüllen könnten und Versorgungslücken entstünden. Er fragt, wie diesen Lücken entgegen gewirkt werden solle. Seine zweite Frage betrifft die Facharztausbildung. Er befürchtet, dass die Ausbildung sich bei den Maximalversorgern konzentrieren werde, wenn Krankenhäuser im ländlichen Raum bestimmte Leistungsgruppen verlören. Dies könne dazu führen, dass die ausgebildeten Ärzte nicht mehr in ländliche Gebiete ziehen würden. Er fragt, wie das geregelt werde.

BMin **Nina Warken** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) antwortet, dass die Regierung sich der Bedeutung der Krankenhäuser im ländlichen Raum für die Ausbildung von Ärzten bewusst sei. Viele niedergelassene Ärzte hätten ihre Ausbildung in diesen Krankenhäusern absolviert und seien danach dort geblieben. Auch in Zukunft solle die Aus-, Fort- und Weiterbildung in den Level-I-Krankenhäusern erfolgen. Die flächendeckende Versorgung sei wichtig. Das Gesetz sehe bereits Ausnahmen vor, und bei der Überarbeitung sei es ein besonderes Anliegen, die bedarfsnotwendigen Krankenhäuser zu erhalten. Den Ländern solle mehr Planungshoheit eingeräumt werden. Die Reformziele zwar auf Spezialisierung, Bündelung und Effizienz ab, aber es solle ein Ausgleich zwischen den Effekten der Reform und der Versorgung in der Fläche geschaffen werden.

Abg. **Thomas Dietz** (AfD) bittet um Klärung bezüglich des Transformationsfonds. Er fragt, ob die von der Ministerin genannten 2,5 Milliarden Euro über 10 Jahre aus Sonderschulden getrennt von den 25 Milliarden Euro von der GKV und den 25 Milliarden Euro von den Ländern zu sehen seien, oder ob er hier etwas verwechsle.

BMin **Nina Warken** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) antwortet, dass es zwei Komponenten gebe. Die Soforttransformationskosten in Höhe von 4 Milliarden Euro, die über einen Rechnungszuschlag an die Krankenhäuser ausgezahlt würden und aus dem Transformationsfonds stammten. Zusätzlich gebe es 4 Zahlungen zu je 3,5 Milliarden Euro und 6 Zahlungen zu je 2,5 Milliarden Euro vom Bund sowie 4 Zahlungen zu je 1,5 Milliarden Euro und 6 Zahlungen zu je 2,5 Milliarden Euro von den Ländern. Die Zahlungen entlasteten die GKV, da sie aus dem Transformationsfonds und nicht von der GKV geleistet würden.

Abg. **Dr. Christos Pantazis** (SPD) äußert seine Sorge, dass die im Koalitionsvertrag angekündigten Ausnahmen und erweiterten Kooperationsmöglichkeiten zur Sicherstellung der Versorgung im ländlichen Raum zu einer Verwässerung der Krankenhausreform führen könnten. Er fragt, wie man diesen Befürchtungen begegne.

BMin **Nina Warken** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) erwidert, dass ihr die Befürchtungen einer Verwässerung der Krankenhausreform bewusst seien. Sie betont, dass es bei den



Nur zur dienstlichen Verwendung

Änderungen um Verbesserungen gehe, die sich an den klaren Vorgaben des Koalitionsvertrags orientierten. Die Reform werde zu einer Reduzierung der Zahl der Krankenhäuser führen, was auch das Ziel der Reform sei. Ziel sei es, die Versorgung in der Fläche durch den Erhalt der bedarfsnotwendigen Krankenhäuser sicherzustellen. Die Umsetzung müsse schnell kommen und auch die Länder seien daran interessiert, zu starten. Es gehe darum, die Reform gangbarer zu machen und der Sorge zu begegnen, dass die Versorgung in der Fläche nicht mehr aufrechterhalten werden könne.

Abg. **Dr. Christos Pantazis** (SPD) fragt zur Weiterentwicklung der Leistungsgruppen, die per Verordnung mit Zustimmung des Bundesrates erfolge. Er berichtet von besorgten Nachrichten einzelner Fachgesellschaften, wie zum Beispiel der Schmerztherapeuten, die darauf hinwiesen, dass die Zeit dränge. Sie forderten, dass umgehend per Gesetz oder Verordnung eine Leistungsgruppe für interdisziplinäre und multimodale Schmerzmedizin ergänzt werde, da ansonsten das Verschwinden bestehender Angebote drohe. Er fragt, wie mit diesen Befürchtungen umgegangen werde.

BMin **Nina Warken** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) erklärt, dass die Weiterentwicklung der Leistungsgruppen bereits intensiv im Leistungsgruppenausschuss diskutiert werde. Der Koalitionsvertrag sehe vor, die Leistungsgruppen zum 1. Januar 2026 auf Basis der 60 NRW-Leistungsgruppen plus der Speziellen Traumatologie zuzuweisen. Sie würden bis zur Evaluation erhalten bleiben, um Planungssicherheit zu schaffen. Sie betont, dass fachlich sinnvolle Leistungsgruppen überprüft würden und die eingehenden Vorschläge im Leistungsgruppenausschuss besprochen würden, um eine gute Lösung zu finden.

Abg. **Dr. Janosch Dahmen** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) äußert sich besorgt über die Ausgaben der GKV für Krankenhäuser, die inzwischen 100 Milliarden Euro überschritten hätten. Er verweist auf die KV-45-Zahlen, die für das erste Quartal 2025 einen Anstieg der Ausgaben für die Krankenhausversorgung zwischen 9 und über 16 Prozent aufwiesen. Er fragt, ob auszuschließen sei, dass die geplanten Änderungen an der Reform zu weiteren

Kostensteigerungen führten.

BMin **Nina Warken** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) antwortet, dass das Ziel der Reform mehr Effizienz sei und die geplante Verbesserung keine Verwässerung bedeute. Sie bekräftigt, dass die Reform nicht nur über Krankenhausschließungen entscheiden solle, sondern auch zu einer Konsolidierung der Finanzen beitragen müsse, um weitere Kostensteigerungen zu vermeiden. Obwohl die Entwicklung schwer vorhersehbar sei, sei ihr Ziel, dass die Reform auch in finanzieller Hinsicht einen Effekt habe. Die Krankenhausreform sei ein essenzieller Baustein, um die Einnahmen- und Ausgabensituation zu beruhigen und Kostensteigerungen zu verhindern. Sie sei sich der diesbezüglichen Sorgen bewusst, halte aber eine wirksame Reform für zwingend notwendig.

Abg. **Johannes Wagner** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) weist darauf hin, dass das Thema Klimaschutz im Gesundheitswesen weder im Koalitionsvertrag noch in der Vorhabenplanung der Ministerin eine Rolle spiele. Da der Gesundheitssektor für rund 6 Prozent der nationalen Emissionen verantwortlich sei, fragt er, welche Vorhaben geplant seien, um diese Emissionen zu reduzieren und den Sektor klimaneutral umzubauen.

BMin **Nina Warken** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) erklärt, dass im Rahmen des Sondervermögens auch Maßnahmen zur Klimaneutralität im Gesundheitswesen angemeldet worden seien. Sie könne die Details nachliefern¹, versichert jedoch, dass das Thema nicht aus dem Blick sei, auch wenn es nicht zu den Hauptpunkten gehöre.

Abg. **Evelyn Schötz** (Die Linke) fragt angesichts des Personalmangels und der schlechten Arbeitsbedingungen in der Pflege, warum die Vorhabenplanung der Bundesregierung bislang weder eine verbindliche Personalbemessung nach dem Modell der Pflegepersonalregelung 2.0 noch gesetzliche Maßnahmen zur nachhaltigen Entlastung und Rückgewinnung von Pflegekräften vorsehe.

BMin **Nina Warken** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) erklärt, dass zwei Gesetze auf den Weg gebracht worden seien, um den Pflegeberuf und die Ausbildung attraktiver zu machen sowie um eine Entlastung der Pflegekräfte zu erreichen.

¹ Antwort lag zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Protokolls noch nicht vor.



Nur zur dienstlichen Verwendung

Sie widerspricht daher der Einschätzung, das Thema nicht im Blick zu haben. Die Ausbildung von Advanced Practice Nurses und der Aufbau von Community Health Services seien ebenfalls Teil des Gesetzespakets.

Abg. **Evelyn Schötz** (Die Linke) fragt nach geplanten Maßnahmen, die verhindern sollten, dass Pflegeassistenten und ungelerntes Personal in unterbesetzten Einrichtungen schleichend Aufgaben übernehmen, die eigentlich Fachkräften vorbehalten seien.

BMin **Nina Warken** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) antwortet, dass es eine klare Aufgabenteilung gebe, auch in der Langzeitpflege, mit einer gewissen Durchlässigkeit je nach Weiterbildungsstufe.

Dr. **Martin Schölkopf** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) ergänzt, dass im Elften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XI) zur Langzeitpflege verschiedene Vorgaben zur Personalbemessung existierten, die nach Ausbildungsniveau gestaffelt seien. Diese Vorgaben gäben den Einrichtungen einen Rahmen, um die Personalbesetzung zu verhandeln. Gleichzeitig sei eine Durchlässigkeit geschaffen worden, die es Pflegekräften und anderen Beschäftigten ermögliche, sich weiter zu qualifizieren. Die Kosten für diese Qualifizierungsmaßnahmen würden für die Einrichtungen angerechnet und refinanziert, um den Beschäftigten Anreize zur Weiterbildung zu geben und sie an die Einrichtung zu binden. Er sehe derzeit keine Problemsituation in diesem Bereich.

Die **Vorsitzende** erklärt, dass der Bereich der Vorhabenplanung, die Tagesordnungspunkte 2a und 2, abgeschlossen sei und man zum sogenannten Sudhof-Bericht, dem Tagesordnungspunkt 2c übergehe.

BMin **Nina Warken** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) bittet um Verständnis dafür, dass der Bericht zuerst im Haushaltsausschuss vorgelegt worden sei, da dieser besondere Wert auf den Primärzugang zu solchen Informationen lege. Sie sei erfreut, dass in dieser Woche die Enquete-Kommission eingesetzt werde, und betont, dass das BMG auf die Aufarbeitung der Inhalte des Sudhof-Berichts vorbereitet sei.

Die Arbeitsergebnisse von Frau Dr. Sudhof könnten nicht direkt als Arbeitsgrundlage dienen, da sich das Ministerium vor der Amtsübergabe nicht damit befasst habe und einige Fragen offengeblieben

seien. In dem Bericht gehe vor allem darum, wie man die Prozesstaktik anders aufstelle und wie aktuelle Rechtsstreitigkeiten zu bewerten seien. Demgegenüber gehe der Bericht aber kaum auf die Vorbereitung auf künftige Pandemien ein und stelle Sachverhalte nicht vollumfänglich dar. Beim Thema Beschaffung räumt sie unterschiedliche Ansichten ein. Sie erinnert daran, dass es im Jahr 2020 eine Ausnahmesituation gegeben habe und fraktionsübergreifend laute Rufe nach mehr Schutzausrüstung zu hören gewesen seien. Sie verteidige die damalige Entscheidung des BMG, selbst Masken zu beschaffen, da die üblichen Wege nicht ausreichen gewesen seien. Sie stimme Frau Dr. Sudhof zu, dass das BMG kein Logistiker sei, betone aber, dass die damalige Situation ein Handeln erfordert habe. Ihr Blick gehe nun nach vorne. Sie wolle das BMG besser aufstellen, Abläufe verbessern und sich um die zahlreichen Rechtsstreitigkeiten kümmern. Sie teile die Kritik von Frau Dr. Sudhof, dass sich das BMG besser um Rechtsstreitigkeiten kümmern können muss. Es sei ihr wichtig, einen offenen, strukturierten und transparenten Prozess zu etablieren. Es gebe aus ihrer Sicht nichts zu verschleiern, alles müsse ordnungsgemäß bewertet werden, um Schlüsse für die Zukunft ziehen zu können.

Abg. **Simone Borchardt** (CDU/CSU) erinnert, dass die Preise für Masken enorm hoch und nicht ausreichend Masken verfügbar gewesen seien. Als damalige Geschäftsführerin einer Pflegeeinrichtung sei sie dankbar gewesen, als das BMG Masken geliefert und die Refinanzierung über § 150 SGB V ermöglicht habe. Sie bittet, noch einmal näher auf die damalige Lage aus Sicht des BMG einzugehen und die Anwesenden in diese Zeit zurückzusetzen.

BMin **Nina Warken** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) erklärt, dass die Situation damals sehr angespannt gewesen sei und dass der Krisenstab regelmäßig getagt habe. Zunächst sei versucht worden, über andere Wege Schutzausrüstung zu beschaffen. Sie erinnert an die harten Debatten im Plenum, da es nicht gelungen sei, ausreichend Masken zu besorgen. Mitarbeiter des BMG hätten geschildert, dass sie Anrufe aus Krankenhäusern erhalten hätten, weil in diesen nur noch Masken für wenige Tage vorhanden gewesen seien. Der Bedarf sei enorm gewesen, nicht nur für den Gesundheitssektor, sondern auch für die Bevölkerung. Sie berichtet von „wilden Zuständen“, in denen vertraglich vereinbarte Lieferungen nicht angekommen



Nur zur dienstlichen Verwendung

oder direkt vom Rollfeld weggekauft worden seien. Die Preise seien enorm gestiegen, und es habe keine festen Preise geben. Sie nennt Beispiele, in denen Kreistage über Bauunternehmen Masken für Millionenbeträge beschafft hätten und die Preise, die Länder wie Baden-Württemberg und Bayern gezahlt hätten, weit auseinandergegangen seien. Sie betont, dass es aus heutiger Sicht einfach sei zu sagen, wie man es hätte besser machen können, aber es bleibe die Tatsache, dass es einen hohen Bedarf geben habe, der durch die vorhandenen Wege nicht habe gedeckt werden können.

Abg. **Simone Borchardt** (CDU/CSU) bittet, die Beschaffungslage und die Beschaffungserfolge während der Corona-Pandemie im internationalen Vergleich einzuordnen. Sie möchte auch wissen, inwieweit die Zusammenarbeit in Europa hilfreich gewesen sei.

BMin **Nina Warken** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) erklärt, dass Deutschland vergleichsweise gut aus der Pandemie gekommen sei, und verweist auf die dramatischen Bilder aus anderen europäischen Ländern wie Italien. Sie führt Großbritannien an, wo die Regierung 18 Milliarden Pfund (circa 21 Milliarden Euro) für Masken ausgegeben habe. Sie betont, dass auch in anderen Ländern viel Geld bezahlt worden sei. Sie erinnert an die damaligen Exportverbote, um den nationalen Bedarf zu decken. Es habe eine Abstimmung mit europäischen Partnern gegeben, jedoch keine gemeinsam abgestimmte europäische Beschaffung, was sie als einen Punkt ansehe, den man für die Zukunft im Blick behalten müsse.

Abg. **Kay-Uwe Ziegler** (AfD) bezieht sich auf den dem Haushaltsausschuss vorgelegten sogenannten Sudhof-Bericht, der als „Verschlussache - Nur für den Dienstgebrauch“ (VS-NfD) eingestuft sei. Er fragt, ob diese Einstufung noch gelte und was im Ausschuss offen besprochen werden dürfe.

BMin **Nina Warken** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) bestätigt, dass der Bericht als VS-NfD eingestuft bleibe, da er so an das BMG übergeben worden sei. Sie bittet darum, die Diskussion über den Bericht möglichst allgemein zu halten.

Abg. **Kay-Uwe Ziegler** (AfD) zitiert aus einem Spiegel-Bericht, in dem die Ministerin das Sudhof-Dokument als lückenhaft und falsch bezeichnet habe. Er bitte um konkrete Beispiele für die

Falschdarstellungen im Sudhof-Bericht.

BMin **Nina Warken** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) entgegnet, dass die Darstellung im Bericht beim Thema Preisermittlung einseitig sei. Es seien zum Beispiel Preislisten der Generalzolldirektion verfügbar gewesen, die in den Arbeitsergebnissen von Frau Dr. Sudhof nicht berücksichtigt worden seien. Insofern sei der Bericht an dieser Stelle lückenhaft. Zudem sei unklar, welche Dokumente dem Bericht zugrunde gelegen hätten und mit welchen Personen Interviews geführt worden seien. Sie weise darauf hin, dass über Betroffene geredet wurde, ohne dass diese selbst befragt worden seien.

Abg. **Kay-Uwe Ziegler** (AfD) fragt, seit wann der Sudhof-Bericht dem BMG vorliege.

BMin **Nina Warken** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) erklärt, dass das Dokument mit der Amtsübernahme als Hardcopy im BMG eingegangen sei. Sie habe sich direkt mit den Ergebnissen befasst und umgehend die Auswertung durch eine Projektgruppe initiiert, um zu vermeiden, dass in die Vorgänge involvierte Personen, das Gutachten bewerteten. Obwohl der Bericht Ende Januar vorgelegen habe, sei nicht im Einzelnen nachvollziehbar, wer vor ihrer Amtsübernahme davon Kenntnis gehabt habe. Es hätten jedenfalls keine Vorarbeiten oder Bewertungen des Dokuments im Haus vorgelegen, als sie das Amt übernommen habe.

Abg. **Kay-Uwe Ziegler** (AfD) fragt, ob das BMG den Sudhof-Bericht nun überarbeite oder einen komplett neuen Bericht erstelle und wann mit diesem zu rechnen sei.

BMin **Nina Warken** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) antwortet, dass es ihre Aufgabe sei, die Ergebnisse des Berichts zu analysieren und, wenn nötig, weitere Erkenntnisse zu sammeln und vor allem Schlüsse zu ziehen. Sie wolle an konkreten Handlungsempfehlungen arbeiten, damit sich das BMG in den Bereichen Bedarfsermittlung, Beschaffung und Prozessführung besser aufstellen könne. Damit werde sich auch die Enquete-Kommission befassen.

Abg. **Dr. Lina Seitzl** (SPD) dankt, dass der Bericht nun auch dem Gesundheitsausschuss zugeleitet worden sei und merkt an, dass schnellere Transparenz einige Gemüter beruhigt hätte. Sie spricht an,



Nur zur dienstlichen Verwendung

dass der Bericht vom Amtsvorgänger beauftragt worden sei, aber nun parteipolitische Motive unterstellt würden, obwohl keine Teile des Berichts im Wahlkampf öffentlich geworden seien. Sie fragt, welche Bedeutung einer transparenten und schonungslosen Aufklärung der Maskenbeschaffung beigemessen werde, um das Vertrauen der Bürger in den Staat zu stärken.

BMin **Nina Warken** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) erklärt, dass der Bericht als VS-NfD eingestuft bleibe. Daher könne man nur beschränkt damit umgehen. Sie betont, dass ihr Transparenz wichtig sei, jedoch aufgrund der Klassifizierung des Berichts Schwärzungen vorgenommen werden mussten und eine Veröffentlichung nicht möglich sei. Der Bericht sei an die zuständigen Ausschüsse weitergeleitet worden. Aus ihrer Sicht handle es sich jedoch um eine vorläufige Bewertung. Sie betont, dass es ihr bei der Bewertung nicht um parteipolitische Motive gehe, sondern darum, was sie mit den Ergebnissen anfangen könne. Sie stellt fest, dass die ursprünglich beauftragten drei Fragestellungen nicht abgearbeitet und stattdessen andere Aspekte beleuchtet worden seien. Es sei zudem unklar, welche Dokumente und Interviews dem Bericht zugrunde gelegen hätten. Obwohl sie den Schutz der Quellen respektiere, fehle eine nachvollziehbare Methodik, die die Herkunft der Aussagen belege. Sie sehe viele Fragezeichen im Bericht und betont, dass dieser oft auf den Bericht des Bundesrechnungshofes Bezug nehme, der bereits Kritik geäußert habe. Es gelte nun, die dargelegten Punkte genauer zu prüfen und Handlungsempfehlungen für die Zukunft abzuleiten. Sie begrüßt die Einsetzung der Enquete-Kommission, die ebenfalls dazu beitragen könne, die Corona-Pandemie als Ganzes aufzuarbeiten und das Vertrauen der Bürger in den Staat zu stärken.

Abg. **Dr. Lina Seitzl** (SPD) stellt klar, dass sie keine vollständige Transparenz des Berichts für die Öffentlichkeit gefordert habe. Sie betont, dass sie sich freut, dass man sich einig sei, Vertrauen und Transparenz zu schaffen und die Enquete-Kommission eingerichtet werde, um aus den Erfahrungen der Vergangenheit für die Zukunft zu lernen.

Abg. **Dr. Janosch Dahmen** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) weist darauf hin, dass der Bericht in der geschwärzten Fassung erst heute um 9:29 Uhr bei den Ausschussmitgliedern eingegangen sei. Er betont, dass es nicht um Fehler in guter Absicht gehe,

sondern um den Vorwurf des Machtmissbrauchs, der mit dem 40-fachen Schaden verglichen mit dem Mautdebakel beispiellos sei. Er unterstreicht, dass es um Aufklärung gehe und nicht nur darum, für die Zukunft zu lernen. Er fragt die Ministerin, ob der damalige Gesundheitsminister und heutige Fraktionsvorsitzende, Abg. Jens Spahn, vor der Versendung des Berichts Kontakt zu ihr aufgenommen und um Einsichtnahme ersucht habe.

BMin **Nina Warken** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) verneint dies.

Abg. **Dr. Janosch Dahmen** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) fragt, ob sie selbst die Gelegenheit gehabt habe, den vollständigen, ungeschwärzten Bericht zu lesen.

BMin **Nina Warken** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) bejaht dies.

Abg. **Dr. Janosch Dahmen** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) fragt, ob die Ministerin ausschließen könne, dass die Schwärzungen, die 70 von 168 Seiten betrafen und von denen 40 Seiten fast vollständig geschwärzt seien, ausschließlich Persönlichkeitsrechte oder laufende Gerichtsverfahren betreffen würden und nicht auch die politische Einschätzung oder die persönliche Verantwortung ihres Amtsvorgängers, Abg. Jens Spahn.

BMin **Nina Warken** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) erklärt, dass die Vorgaben für die Schwärzungen klar seien. Sie betont, dass die Schwärzungen aufgrund von laufenden Prozessen, erfolgten Vergleichen, Rechten Dritter, Interessen des Bundes und Persönlichkeitsrechten vorgenommen worden seien. Es gäbe keine politischen Gründe für die Schwärzungen.

Abg. **Dr. Janosch Dahmen** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) präzisiert seine Frage. Er fragt die Ministerin, ob sie ausschließen könne, dass die Schwärzungen auch Teile betrafen, die politische Bewertungen des Vorgangs zum Inhalt hätten und nicht ausschließlich oder überwiegend Persönlichkeitsrechte oder laufende Gerichtsverfahren.

BMin **Nina Warken** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) erklärt, dass die großflächigen Schwärzungen im Bericht laufende Rechtsstreitigkeiten und geschlossene Vergleiche betrafen, die sie aus Gründen des Bundesschadens nicht offenlegen könne. Sie bitte um Verständnis für diese Einschränkung. Im Übrigen seien nur einzelne Worte



Nur zur dienstlichen Verwendung

oder Bezeichnungen geschwärzt. Sie weist die Behauptung zurück, dass die Schwärzungen politisch motiviert seien.

Abg. **Dr. Janosch Dahmen** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) fragt, wie es sein könne, dass in geschwärzten Teilen des Berichts laut Spiegel-Berichterstattung eine Aktennotiz des Unternehmens Fiege erwähnt werde, in der angekündigt worden sei, im Falle einer Schadensersatzklage gegen den damaligen Gesundheitsminister auszusagen. Er argumentiert, dass es sich dabei weder um ein laufendes Gerichtsverfahren noch um Persönlichkeitsrechte handele. Er möchte wissen, warum dieser Teil geschwärzt sei.

BMin **Nina Warken** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) gibt an, die entsprechende Spiegel-Berichterstattung nicht zu kennen und daher nicht beurteilen zu können, ob der zitierte Teil so im Bericht enthalten und geschwärzt sei.

Abg. **Dr. Janosch Dahmen** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) fragt, welche Rechte eine Enquete-Kommission habe, um Zeugen zu laden, Akten anzufordern und Beweise zu sichern.

BMin **Nina Warken** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) entgegnet, dass eine Enquete-Kommission natürlich weniger Rechte als ein Untersuchungsausschuss habe. Sie betont, dass sie als Ministerin nicht mehr Teil des parlamentarischen Verfahrens sei, die Einsetzung der Kommission aber begrüße. Sie sei überzeugt, dass die Kommission sich mit der Vergangenheit auseinandersetzen werde, um Lehren für die Zukunft zu ziehen, und verspricht, die Arbeit der Kommission nach Kräften zu unterstützen, insbesondere bei Auskunftswünschen. Sie wisse, dass die beiden Gremienarten unterschiedliche rechtliche Befugnisse hätten.

Abg. **Ates Gürpinar** (Die Linke) fragt nach dem konkreten Auftrag an Frau Dr. Sudhof. Er beziehe sich auf den Bericht über den Bericht, in dem der Auftrag aus einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Union vom letzten Jahr zitiert werde. Er fragt, ob dem BMG der Auftrag vorliege und ob dieser, falls vorhanden, dem Ausschuss vorgelegt werden könne.

BMin **Nina Warken** (Bundesministerium für

Gesundheit (BMG)) antwortet, im Haushaltsausschuss sei dazu berichtet worden und die Beauftragung liege dem BMG auch vor.

Abg. **Ates Gürpinar** (Die Linke) bittet um Übermittlung des Auftrags.² Er fragt, ob der Bericht tatsächlich weiterhin nur in Papierform vorliege.

BMin **Nina Warken** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) bejaht dies. Er sei mittlerweile aber eingescannt.

Abg. **Ates Gürpinar** (Die Linke) fragt, wie es sein könne, dass das BMG nicht rekonstruieren könne, wann Frau Dr. Sudhof den Bericht übergeben habe, obwohl die Ministerin angegeben habe, bei Amtsantritt Einsicht in den Bericht gehabt zu haben. Er halte dies für ungeheuerlich und fragt, warum die Rekonstruktion nicht möglich sei, da normalerweise jeder Posteingang kontrolliert und protokolliert werde.

BMin **Nina Warken** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) erklärt, dass ihr nur das Dokument vorgelegen habe, das Frau Dr. Sudhof der ehemaligen Hausleitung übergeben habe. Nach ihrem Kenntnisstand habe sonst niemand im Haus Kenntnis von dem Bericht gehabt. Sie bestätigt, dass Frau Dr. Sudhof ihre Tätigkeit Ende April beendet und sich zu diesem Zeitpunkt an die damalige Hausleitung gewandt habe, um den Bericht zu übergeben. Sie könne diesen Vorgang nicht weiter nachvollziehen.

Abg. **Ates Gürpinar** (Die Linke) merkt an, dass er angesichts der von der Ministerin geschilderten Mängel im Protokollwesen des BMG die harsche Kritik an der Arbeit von Frau Dr. Sudhof, die im Bericht über den Bericht enthalten sei, für unangemessen halte.

BMin **Nina Warken** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) entgegnet, sie habe es so vorgefunden.

Abg. **Ates Gürpinar** (Die Linke) fragt, ob das BMG systematisch geprüft habe, ob Abgeordnete oder Angehörige des damaligen Ministeriums oder deren Angehörige an Firmen beteiligt gewesen seien, die im Rahmen der Maskenvergabe Aufträge oder Zahlungen erhalten hätten. Falls dies nicht

² Dokument lag zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Protokolls noch nicht vor.



Nur zur dienstlichen Verwendung

geschehen sei, wolle er den Grund dafür erfahren.

BMin **Nina Warken** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) erklärt, dass sie nicht sagen könne, ob eine solche Prüfung stattgefunden habe. Dies sei mit der vorherigen Hausleitung zu besprechen.

Abg. **Ates Gürpinar** (Die Linke) merkt an, dass von den 11 Milliarden Euro an Verpflichtungen bisher nur 7 Milliarden Euro in den Bundeshaushalten veranschlagt seien und fragt, in welcher Höhe die fehlenden 4 Milliarden Euro in den beiden aktuell erarbeiteten Haushaltsgesetzen berücksichtigt seien.

Martin Schölkopf (BMG) antwortet, dass die Summe, die hier in Rede stehe, bei 2,3 Milliarden Euro liege. Er verweist auf den schriftlichen Bericht, in dem dies im Rahmen der Bundeshaushaltsordnung und des sogenannten Corona-Titels dargelegt sei. Er erklärt, dass dafür Ausgabenreste vorhanden seien und diese jetzt veranschlagt seien. Er bietet an, die exakte Zahl nachzuliefern³, könne jedoch die genannten 11 Milliarden Euro nicht direkt nachvollziehen.

Abg. **Ates Gürpinar** (Die Linke) fragt, wer die Einstufung als Verschlussache vornehme.

BMin **Nina Warken** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) antwortet, die Einstufung werde vom Verfasser vorgenommen.

Abg. **Ates Gürpinar** (Die Linke) fragt, ob dies Frau Dr. Sudhof sei.

BMin **Nina Warken** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) bejaht dies.

Die **Vorsitzende** bedankt sich für die Antworten der Ministerin und verabschiedet sie. Sie unterbricht die Sitzung, um die Gäste für das nachfolgende Fachgespräch hereinzubitten.

11:17 Uhr bis 11:21 Uhr Sitzungsunterbrechung

Tagesordnungspunkt 3

Fachgespräch zum jüngsten Schiedsspruch zum Vertrag über die Hebammenhilfe mit dem

Schwerpunkt zur Situation der Beleghebammen

Selbstbefassung S-21(14)8

Ilona Strache (1. Vorsitzende des Bundes freiberuflicher Hebammen Deutschlands (BfHD)) erklärt, das Ziel aller Beteiligten am neuen Hebammenhilfsvertrag sei neben der Stärkung der individuellen Geburtshilfe die dringend notwendige Aufwertung aller Hebammenleistungen. Es habe ein Ausgleich des momentan bestehenden Einkommensgefälles innerhalb der freiberuflichen Hebammen erwirkt werden sollen. Die erreichte Stärkung der außerklinischen Geburtshilfe und der Begleit-Beleghebammen stelle nun einen Anreiz dar, dieses Angebot auszubauen und der gesetzlich zugesicherten freien Wahl des Geburtsortes eine Chance zu geben. Der Kompromiss zur Einigung auf 74,28 Euro für den außerklinischen Bereich und damit unter der Grundlohnsummensteigerung zu bleiben, sei notwendig gewesen, um den neuen Vertrag zeitnah umsetzen zu können und mit einer kurzen Laufzeit zu versehen. Nach vier Jahren Verhandlung sei dies allerdings nur eine vorübergehende Lösung, da die Hebammen mehr verdient hätten. Für die Zustimmung zum Vertrag sei daher Bedingung gewesen, dass keine Hebamme schlechter gestellt werden dürfe als bisher. Für den Fall einer Verschlechterung der Einkommenssituation habe man sich dementsprechend für die im Vertrag verankerte Protokollnotiz stark gemacht. Die neu eingerichtete Arbeitsgruppe müsse nun Lösungen erarbeiten und den Vertrag evaluieren und prospektiv statt retrospektiv denken. Bei den Dienst-Beleghebammen zeichne sich großer Widerstand gegen den neuen Vertrag ab, da Einkommenseinbußen befürchtet würden. Die Selbstverwaltung müsse dies zügig und unabhängig prüfen und gegebenenfalls schnellstmöglich und nicht erst mit einem neuen Vertrag nach 2027 entgegensteuern. Jede Frau habe nach dem SGB V einen ortsunabhängigen Anspruch auf Hebammenhilfe. Freiberufliche Hebammen in Krankenhäusern überlegten derzeit, ob sie nach dem 1. November 2025 überhaupt weiterarbeiten sollten. Bei der Frage, ob es weitere Möglichkeiten für nachsteuerbare Lösungen für absehbare Probleme in der Flächenversorgung gebe, dürfe nicht erst in Zukunft darauf geschaut werden, was verbessert werden könne. Dies gehe neben der

³ Antwort lag zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Protokolls noch nicht vor.



Nur zur dienstlichen Verwendung

beruflichen und wirtschaftlichen Perspektive nämlich auch auf die Kosten der Gebärenden. Der Bund freiberuflicher Hebammen Deutschland (BfHD) setze große Hoffnungen in die konstruktive Arbeit der Arbeitsgruppe mit dem Ziel, Hilfestellungen für konkrete Verhandlungen mit den Kliniken und notwendige Anpassungen der Arbeits- und Abrechnungsstrukturen zu ermöglichen.⁴

Ulrike Geppert-Orthofer (Präsidentin des Deutschen Hebammenverbands (DHV)) gibt an, die Lage sei sehr ernst. Man laufe sehenden Auges in ein Versorgungsproblem bei der klinischen Geburtshilfe und der geburtshilflichen Notfallversorgung. Grund dafür sei der neue Hebammenhilfvertrag, der die Beleghebammen ab dem 1. November 2025 deutlich schlechter stellen werde. Die Selbstverwaltung habe an dieser Stelle versagt. Als Vertragspartner komme man allein aus dieser Misere nicht heraus, sodass am Ende die Frauen, Kinder und Familien mit ihrer Gesundheit den Preis zahlten. Wenn nun nicht zeitnah gehandelt und lediglich der 1. November 2025 abgewartet werde, würden die Beleghebammen die Geburtshilfe verlassen. Die Umfragen seien dazu eindeutig, etwa die Hälfte der Teams würden in sechs Monaten keine geburtshilfliche Tätigkeit mehr erbringen können. Die entscheidende Frage sei, wer diese Abwanderung von Fachkräften ausgleichen solle. Es müsse schon jetzt verhindert werden, dass die Hebammen massenhaft die Geburtshilfen verließen. Viele Flächenländer nutzten – gerade in strukturschwachen Gebieten – die Flexibilität des Belegsystems, aber auch Level-I-Kliniken arbeiteten häufig mit Beleghebammen aufgrund der überzeugenden Eins-zu-eins-Betreuung. Der GKV-Spitzenverband ignoriere, dass Beleghebammen nach acht Jahren ohne Vergütungserhöhung nun empfindliche Einbußen erlitten. Dies zu berechnen, sei kein Hexenwerk. Die Daten lägen alle vor. Der Eins-zu-eins-Betreuungsbonus sei nicht praxistauglich und die aktive Sanktionierung der Eins-zu-zwei-Betreuung breche dem Belegsystem das Genick. Dabei sei zudem nicht berücksichtigt, dass ambulante Leistungen zukünftig für Hebammen nicht mehr vergütet werden sollten. Aufgrund dieser Rechnung kämen die Hebammen zu dem Ergebnis, nicht weiter in der klinischen Geburtshilfe arbeiten zu wollen, auch nicht als angestellte Hebammen. Derzeit seien sich nur 8,4

Prozent sicher, in der klinischen Geburtshilfe zu bleiben. Es brauche daher schnelle Lösungen aus der Politik.⁵

Dr. Christine Bruhn (Vorstandsmitglied des Netzwerks der Geburtshäuser) erläutert, der Hebammenhilfvertrag decke mit seiner Gebührenordnung die gesamte Bandbreite der Hebammenleistungen ab, sodass die Vertragspartner die Verantwortung für das Gesamtsystem trügen. Es müssten daher in jeder Konstellation die Rahmenbedingungen und Vergütung stimmen. Der nun geschlossene Hebammenhilfvertrag bringe zahlreiche Verbesserungen mit sich, beispielsweise die Umstellung von Pauschalen auf zeitbasierte Abrechnung im Rahmen der Vergütung. Zudem sei darauf geachtet worden, in jedem Bereich die Eins-zu-eins-Betreuung zu honorieren und zu stärken. Die Verhandlungen seien sehr langwierig gewesen, da der Vertrag auch strukturell neu aufgesetzt worden sei. Es sei ein neues Kalkulationsmodell entwickelt worden, was sich an tariflichen Strukturen orientiere, zukunftssträftig sei und eine Grundlage für freiberufliche Hebammen biete, die auch ein unternehmerisches Risiko trügen. Damit habe man die Kassenseite überzeugen können und durch die einberufene Schiedsstelle seien weitere Verbesserungen eingebracht worden. Allerdings bringe ein Vertrag mit vielen neuen Stellschrauben auch mit sich, dass im Vorfeld nicht alle Wechselwirkungen hundertprozentig exakt bestimmt werden könnten. Dies sei in einem solchen Honorarverteilungssystem immanent. Die Befürchtung von Einkommenseinbußen sei verständlich, sodass es umso wichtiger sei, dass die Vertragsumsetzung genau geprüft und evaluiert werde. Die Vergütung von Beleghebammenteams in den Kliniken sei wegen der Überschneidung von zwei unterschiedlich strukturierten und finanzierten Systemen sehr komplex und die Abrechnungsdaten hätten erst zum Ende der Verhandlungen vorgelegen, auf deren Basis eine Vergütungserhöhung vereinbart werden können. Zur Absicherung sei sodann die paritätisch besetzte Arbeitsgruppe zur Begleitung der Vertragsumsetzung eingesetzt worden, die Probleme aufgreifen und Fehlentwicklungen schnellstmöglich korrigieren solle. Diese treffe sich erstmals Anfang Juli. Sofern die

⁴ Anlage: BfHD-Stellungnahme (Ausschussdrucksache 21(14)6)

⁵ Anlagen: DHV-Stellungnahme (Ausschussdrucksachen 21(14)4 und 21(14)4.1)



Nur zur dienstlichen Verwendung

offenbar zunehmende Unsicherheit bei den Beleghebammenteams Kündigungswellen auslöse und dadurch die Versorgungssicherheit gefährdet werde, müsse die Arbeitsgruppe mit geeigneten Mitteln und schnell innerhalb der nächsten Wochen für Sicherheit sorgen.⁶

Steffen Waiß (GKV-Spitzenverband) führt aus, die Verhandlungen zum Hebammenhilfevertrag hätten nach vier Jahren im April durch den Schiedsspruch der ehemaligen Bundesministerin der Justiz Brigitte Zypries abgeschlossen werden können. Der neue Vertrag bringe wesentliche Verbesserungen sowohl für die schwangeren Frauen als auch für die freiberuflichen Hebammen. Es seien neue Leistungen integriert worden. So gebe es nun eine individuelle Stillvorbereitung zur Steigerung der Stillquote und einen vereinfachten Zugang zur Fehlgeburtshilfe. Auch seien Video-Tutorials zur Geburtsvorbereitung und für Rückbildungskurse möglich. Im Bereich der ambulanten Hebammenversorgung werde die Stundenvergütung von 56 Euro auf circa 74 Euro erhöht. Zudem seien Zeitkontingente eingeführt worden, die eine individuelle und fundierte Betreuung, beispielsweise im frühen Wochenbett, ermöglichen würden. Im klinischen Bereich sei das Ziel des GKV-Spitzenverbandes gewesen, möglichst vielen Frauen eine Geburt unter Eins-zu-eins-Betreuung zu ermöglichen, da diese Versorgungsform als optimal gelte. Dazu gebe es auch eine aktuelle S3-Leitlinie. Die Vergütung pro Stunde für die Eins-zu-eins-Betreuung einer Geburt werde mehr als verdoppelt, während die Vergütung für eine Eins-zu-zwei-Betreuung leicht und für eine Zwei-zu-drei-Betreuung etwas stärker abgesenkt werde. Es handele sich dabei keineswegs um ein Sparprogramm, da die GKV hier vielmehr mit Mehrausgaben von 100 Millionen Euro rechne. Dies geschehe trotz der prekären Finanzlage der GKV, deren Krankenversicherungsbeiträge derzeit auf Rekordhöhe lägen und weitere Steigerungen angekündigt seien. Daher sei ein effizienter Mitteleinsatz über alle Leistungsbereiche notwendig, damit die gesundheitliche Versorgung der Menschen bezahlbar bleibe und das Vertrauen in das solidarische Sicherungssystem und dessen Akzeptanz nicht verloren gingen. Nach Einschätzung des GKV-Spitzenverbandes sei eine auskömmliche Vergütung der Beleghebammen sichergestellt. Ein

monatlicher Umsatz von 8 000 Euro sei problemlos realisierbar, wenn ein Drittel der Zeit mit Eins-zu-eins-Betreuung, ein weiteres Drittel mit einer Mischbetreuung (Eins-zu-zwei oder Eins-zu-drei) und das letzte Drittel in Bereitschaft verbracht werde. Dies entspreche einer höheren Vergütung als der eines Assistenzarztes und nur einer geringfügig geringeren Vergütung als der eines Facharztes. Zum Vorwurf des Versagens der Selbstverwaltung stellt er klar, dass die Berechnungen des Deutschen Hebammenverbandes (DHV) zu den Beleghebammen dem GKV-Spitzenverband bisher nicht zugeleitet worden seien. Man sei irritiert darüber, dass dies nun über die Öffentlichkeit und im politischen Raum geschehe. Dies hätte während der vierjährigen Vertragsverhandlungen erfolgen müsse. Die Zahlen seien nicht vorgelegt worden, obwohl sie in den Verhandlungen sowohl vom BfHD als auch vom GKV-Spitzenverband eingefordert worden seien. Daraufhin habe der DHV die Verhandlungen verlassen und die Schiedsstelle angerufen. Er betont, dass etablierte Verfahren zur Preisfindung in der Selbstverwaltung unbedingt genutzt werden sollten. Es dürfe kein Präzedenzfall geschaffen werden, der eine Schiedsstellenentscheidung ad absurdum führen würde.⁷

Prof. Henriette Neumeyer (Stellv. Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG)) legt dar, obwohl die Kliniken keine Vertragspartei seien, seien sie ebenfalls von der gefundenen Lösung, die zum 1. November in Kraft treten solle, betroffen. Die Grundidee des Hebammenhilfevertrags, die Vergütungssituation zu verbessern, sei richtig, da Hebammen seit 2017 keine Anpassung an die Inflationsrate erfahren hätten und in der Zwischenzeit tarifliche Erhöhungen stattgefunden hätten. Auch die Widmung an das Thema der Qualität der geburtshilflichen Versorgung werde ausdrücklich begrüßt. Der vorliegende Vertrag Sorge jedoch für erhebliche Verunsicherung in den Kliniken. Die Kliniken erhielten Brandbriefe, in denen die Versorgungssituation bereits mit Inkrafttreten des neuen Vertrages als gefährdet angesehen werde. Dazu gehörten Kündigungsandrohungen von Beleghebammenteams, die sich aufgrund der sich verschlechternden Vergütungssituation – im Schnitt eine Reduktion zwischen 15 und 30 Prozent über

⁶ Anlage: Netzwerk der Geburtshäuser Stellungnahme (Ausschussdrucksache 21(14)8)

⁷ Anlage: GKV-Spitzenverband Stellungnahme (Ausschussdrucksache 21(14)7)



Nur zur dienstlichen Verwendung

alle Geburten hinweg – nicht in der Lage sähen, ihre Arbeit fortzusetzen. Die Verteilung der Beleghebammenteams in den Krankenhäusern sei heterogen. Im Schnitt seien etwa 15 Prozent der Krankenhäuser abhängig vom Einsatz von Beleghebammen in der Geburtshilfe, in einigen Bundesländern reiche dieser Anteil sogar bis zu 60 Prozent. In diesen Regionen sei die Besorgnis entsprechend größer. Das werde aus den Rückmeldungen aus den Bundesländern deutlich. Ein Punkt betreffe die Vergütungslogik und die Eins-zu-eins-Betreuung, die aus Sicht der Kliniken nochmals aufgegliedert werden müsse. Die Eins-zu-eins-Betreuung sei für bestimmte, aktive Phasen der Geburt gedacht, nicht für Phasen, in denen die Frauen beispielsweise noch spazieren oder sich mit ihrem Partner austauschen könnten. Die im Vertrag vorgesehene Eins-zu-drei-Abwertung betreffe jedoch auch diese Geburtsphasen. Dies bedeute, dass es nun pönalisiert werde, wenn eine Hebamme richtig handle und die Frauen im richtigen Moment allein lasse, um in der Zwischenzeit anderen Frauen zu helfen. Geburten seien jedoch keine aufschiebbaren Ereignisse, sodass diese Abwertung nicht geeignet sei, die Versorgungssituation zu verbessern. Die Kliniken sähen die aktuelle Versorgungssituation als bedroht an und schlossen sich der Forderung an, dass die genannten Ziffern ab dem 1. November 2025 in dieser Form nicht realisiert werden könnten. Auch die geplante Evaluation zum 1. November 2025 werde als zu spät erachtet, da bereits jetzt Versorgungseffekte antizipiert würden. Obwohl die Kliniken grundsätzlich eine Integration und eine Zusammenarbeit in Teams anstrebten, versicherten sie, dass dies bis zum Herbst nicht realitätsnah sei.

Abg. **Emmi Zeulner** (CDU/CSU) greift die bereits angesprochene Sorge auf, ob die Versorgung künftig in Regionen sichergestellt werden könne, in denen die Geburtshilfe ganz oder größtenteils von Beleghebammen organisiert werde. Sie bittet Prof. Dr. Neumeyer um Erläuterung der Befürchtungen der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG). Insbesondere interessiere sie, welche Konsequenzen für die Krankenhäuser drohen würden, falls es nicht gelinge, die Hebammenteams zu halten.

Prof. Henriette Neumeyer (Stellv. Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG)) antwortet, dass die Landeskrankenhausgesellschaften mit hohem Betroffenheitsgrad

eindeutig signalisiert hätten, dass sie ohne Beleghebammen nicht in der Lage wären, die Versorgung aufrechtzuerhalten. Es gebe keine andere Instanz, die das Versorgungsvolumen auffangen könne. Der Wunsch sei es, mit den Beleghebammen auch intersektoral zusammenzuarbeiten. Für die Kliniken bedeute dies essenzielle Versorgungsprobleme, für die aktuell keine Vertretungslösung seitens der Häuser angeboten werden könne.

Abg. **Emmi Zeulner** (CDU/CSU) richtet ihre Frage an Ulrike Geppert-Orthofer. Sie weist darauf hin, dass Hebammen auch ambulant in den Kreißsälen einen Ausgleich für die Versorgung von Frauen und Familien leisteten. Sie möchte wissen, welche Konsequenzen es hätte, wenn es tatsächlich keine Kreißsäle mehr geben würde. Sie fragt, was dies für die Notfallversorgung bedeuten würde.

Ulrike Geppert-Orthofer (Präsidentin des Deutschen Hebammenverbands (DHV)) bestätigt, dass freiberufliche Hebammen die Versorgung außerhalb der Geburt sicherstellten. Das eigentliche Problem liege jedoch in der Notfallversorgung, wenn eine Frau ad hoc Unterstützung brauche. Bislang sei sie in solchen Fällen in den Kreißsaal gegangen, wo sie Anspruch auf Hebammenhilfe habe. Solange es den Kreißsaal gebe, werde sie diese Hilfe dort erhalten, doch die Hebammen bekämen dies nicht bezahlt. Wenn der Kreißsaal nicht mehr existiere, habe die Frau in Notfällen lange Anfahrtswege. Sie könne zwar eine Hebamme vor Ort anfragen, diese müsse aber ebenfalls sehen, wie sie bei Bedarf wirklich weiterkomme. Es werde eindeutig auf dem Rücken der Frauen ausgetragen werden, wenn die Kreißsäle schließen müssten.

Abg. **Emmi Zeulner** (CDU/CSU) äußert ihren ausdrücklichen Dank an die Vertreter des GKV-Spitzenverbands für deren Anwesenheit. In Bezug auf die angesprochene Evaluation, deren Bedarf auch der GKV-Spitzenverband sehe, fragt sie, ob es eine Möglichkeit gebe, diese vorzuziehen. Da der GKV-Spitzenverband selbst davon spreche, dass die Zahlen noch nicht vorhanden und eingereicht seien und der Stichtag der November sei, müsse man vor die Welle kommen, und die tatsächlichen Auswirkungen des Vertrags gesondert betrachten.

Felix Engelhard (GKV-Spitzenverband) führt aus, dass eine Evaluation bereits in den Vertragsverhandlungen stattgefunden habe. Er erklärt, dass der BfHD im August 2024 vorgeschlagen habe,



Nur zur dienstlichen Verwendung

Abrechnungsdaten beizuziehen. Dies sei für den DHV der Anlass gewesen, aus den Verhandlungen auszusteigen. Der DHV habe das Einbringen von Abrechnungsdaten als Belastung für Verhandlungen angesehen und daher abgelehnt. Daraufhin habe die GKV die Evaluation in kleinerem Kreis mit dem BfHD und dem Netzwerk der Geburtshäuser durchgeführt, wobei Beleghebammenteams genau angeschaut und evaluiert worden seien. Man sei zu dem Ergebnis gekommen, dass das neue System funktioniere. Auch bezüglich der Zeiträume für die Evaluation habe man sich Gedanken gemacht. Die Schiedsstelle habe hier die kürzest möglichen Zeiträume gewählt, auch hinsichtlich der Vertragslaufzeit. Die Kassenseite habe vorgeschlagen, ein rollierendes System einzuführen, wie es in anderen Leistungsbereichen üblich sei, um nach zwei Quartalen abzurechnen und so schneller einen Überblick über die Abrechnungsdaten zu erhalten. Dieser Vorschlag habe sich jedoch gegenüber den Hebammenverbänden leider nicht durchsetzen lassen. Nach aktuellem Stand könne bis zum 30. Juni des Folgejahres abgerechnet werden, was einen gewissen Vorlauf bedeute, bevor die Resultate bei den Abrechnungen sichtbar seien. Dies sei die Evaluation. Natürlich werde man sich die Zahlen auch in der Arbeitsgruppe nochmal anschauen.

Abg. **Emmi Zeulner** (CDU/CSU) fragt, ob eine Budgetneutralität denkbar sei, um den Druck für die Beleghebammen herauszunehmen, da ein rollierendes System bereits eine gewisse Ähnlichkeit aufweise.

Felix Engelhard (GKV-Spitzenverband) erklärt, die Problematik sei, dass mit Fallzahlen gearbeitet werden müsse. Eine Budgetneutralität setze voraus, dass diese konstant blieben. Auf Kassenseite bestehe beispielsweise ein Kostenrisiko bei der Wochenbettbetreuung, auf Hebammenseite bei den Beleghebammen. Hier müssten beide Seiten zusammenkommen.

Abg. **Dr. Christina Baum** (AfD) möchte von Ulrike Geppert-Orthofer den Unterschied zwischen Beleghebammen und freiberuflichen Hebammen wissen. Da auch Beleghebammen freiberuflich arbeiteten erschließe sich ihr nicht, warum diese weniger verdienen sollten.

Ulrike Geppert-Orthofer (Präsidentin des Deutschen Hebammenverbands (DHV)) erklärt, Beleghebammen seien freiberufliche Hebammen, die

einen Versorgungsvertrag mit einem Krankenhaus hätten. Sie stellten die Versorgung 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche in einem Team sicher und rechneten ihre Leistungen direkt mit den Krankenkassen ab. Es sei unverständlich, warum diese Kolleginnen weniger verdienen sollten als die Kolleginnen, die freiberuflich außerhalb eines Krankenhauses die Leistung erbringen würden. Dies sei eine Abwertung der Arbeit der Beleghebammen im Krankenhaus.

Abg. **Dr. Christina Baum** (AfD) äußert ihr Unverständnis darüber, warum eine Hebamme, die mehrere Frauen betreue, nun weniger verdienen solle als eine, die in der Eins-zu-Eins-Betreuung tätig sei. Sie erkennt, dass die Qualität gehoben werden solle, vermutet jedoch, dass die Betreuung mehrerer Frauen oft auch eine Folge der größeren Nachfrage als des Angebots sei. Sie möchte wissen, ob es bei einer finanziellen Schlechterstellung dieser Personen nicht auf jeden Fall zu einem Mangel und zu einem Versorgungsproblem kommen werde.

Felix Engelhard (GKV-Spitzenverband) antwortet, dass keine Schlechterstellung erfolge, sondern eine Umverteilung im System vorgenommen werde. Bisher löse die Betreuung jeder Frau dieselbe Vergütung aus, was bedeute, dass die qualitativ hochwertige Eins-zu-eins-Betreuung sehr viel schlechter vergütet werde als die Betreuung von drei Frauen parallel. Um die Eins-zu-eins-Betreuung finanziell zu stärken, müsse man das System verlassen, in dem jede betreute Frau dieselbe Vergütung auslöse. Die Vergütung der Eins-zu-eins-Betreuung sei so stark angehoben worden, dass in der Gesamtschau die Absenkung bei der Eins-zu-drei-Betreuung ausgeglichen werde. Der Vergütungssatz für die klinisch tätigen Hebammen werde auch im Vergleich zu den außerklinisch Tätigen betrachtet, da Beleghebammen die Infrastruktur des Krankenhauses mitnutzten und deswegen eine niedrigere Kostenstruktur hätten. Daraus resultiere die unterschiedliche Stundenvergütung zwischen einer Beleghebamme und einer außerklinisch tätigen Hebamme. Es seien nicht die Lohnkosten verändert worden, sondern man habe lediglich die Betriebskosten betrachtet, die zwischen diesen beiden Gruppen unterschiedlich seien.

Abg. **Dr. Christina Baum** (AfD) hakt nach, ob eine Eins-zu-eins-Betreuung realistisch sei und ob es dafür genug Hebammen gebe.



Nur zur dienstlichen Verwendung

Felix Engelhard (GKV-Spitzenverband) führt aus, man sei – wie auch der DHV – der Meinung, dass eine Eins-zu-eins-Betreuung möglich sei. Dazu lägen auch Veröffentlichungen vor. Er verweist auf aktuelle Trends wie sinkende Geburtenzahlen sowie die Zunahme der Hebammen im System aufgrund der Akademisierung. Die Berechnungen des DHV in der aktuellen Kampagne für die Eins-zu-eins-Betreuung bezögen sich ebenfalls auf diese Zahlen. Zudem spreche der DHV von einer stillen Reserve von Hebammen, die bei entsprechenden Arbeitsbedingungen auch in die Versorgung zurückkommen wollten. Die Eins-zu-Eins-Betreuung sei das, was die Frauen, die Hebammen und auch die Krankenkassenseite wünschten.

Abg. **Dr. Christina Baum** (AfD) spricht eine Umfrage an, nach der die Hälfte der befragten Hebammenteams eine Kündigung in den nächsten drei bis sechs Monaten in Erwägung ziehe. Sie fragt, wie eine massenhafte Kündigungswelle abgewendet werden solle.

Ulrike Geppert-Orthofer (Präsidentin des Deutschen Hebammenverbands (DHV)) sagt, die Kolleginnen äußerten sehr glaubhaft, sie würden so nicht weiterarbeiten. Sie stimme Felix Engelhard zu, dass alle eine Eins-zu-eins-Betreuung wünschten. Die Kolleginnen, die dies sicherstellten, indem sie zusätzlich in der Klinik arbeiteten, wollten von ihrer Arbeit leben können. Es müsse mehr Geld ins System gehen. Der GKV-Spitzenverband habe selbst angegeben, dass es durch den neuen Hebammenhilfsvertrag 100 Millionen Euro mehr für Hebammenleistungen geben werde. Dies entspreche einer Erhöhung des Gesamtvolumens um 12,6 Prozent. Die Grundlohnsummensteigerung im entsprechenden Zeitraum sei jedoch deutlich höher, aktuell über 20 Prozent, und werde bis 2027 25 Prozent erreichen. Dieses Delta von 12,4 Prozent müsste geschlossen und zusätzlich obendrauf gelegt werden. Ein Ausgleich sei auch ohne Gefährdung der Beitragssatzstabilität möglich.

Abg. **Dr. Lina Seitzl** (SPD) richtet ihre Frage an den GKV-Spitzenverband. Der Vertrag starte zum 1. November und da es sich um freiberuflich tätige Hebammen handle, überlegten diese schon jetzt und nicht erst zum 1. November, wie es weitergehe. Sie fragt, wie der GKV-Spitzenverband auf diese Situation reagieren wolle, insbesondere dort, wo viele Kreißsäle von Beleghebammen geführt seien.

Steffen Waiß (GKV-Spitzenverband) äußert, der GKV-Spitzenverband sehe die angekündigte Rücktrittswelle nicht. Es werde eine Vertragspartnerliste geführt, in der Kündigungen auffielen. Im Vordergrund stehe für den GKV-Spitzenverband die Verbesserung der Versorgung der schwangeren Frauen mit einer leitlinienkonformen Eins-zu-eins-Betreuung. Die Frage sei, wie man diese erreiche. Man sei der Ansicht, dies nicht durch den Fehlanreiz einer besseren Vergütung der der Eins-zu-zwei- oder Eins-zu-drei-Betreuung zu erreichen, sondern vielmehr durch eine Verdoppelung und Aufwertung der Eins-zu-eins-Betreuung. Mehr Geld in das System fließen zu lassen, werde nicht die Eins-zu-eins-Betreuung sichern. Es gebe nach Ansicht des GKV-Spitzenverbandes keine Hinweise für den angedrohten Rückzug der Hebammen und es sei unredlich, dass die gemeinsam mit der Selbstverwaltung geführten Verhandlungen derart diskreditiert würden. Nun gebe es einen fundierten Schiedsspruch. Wie bereits erwähnt, sehe man problemlos die Möglichkeit einer Vergütung von 8 000 Euro monatlich.

Abg. **Dr. Lina Seitzl** (SPD) fragt, wie der GKV-Spitzenverband reagieren würde, falls in den nächsten Monaten ein Rückgang erfolgen würde.

Steffen Waiß (GKV-Spitzenverband) betont, der GKV-Spitzenverband habe kein Interesse an einer Verschlechterung der Hebammenversorgung in Deutschland. Sollten sich entsprechende Entwicklungen abzeichnen, werde man diese prüfen. Es gebe jedoch etablierte Verhandlungsstrukturen, die beibehalten werden sollten. Sollte die Versorgung tatsächlich gefährdet sein, werde der GKV-Spitzenverband eine geeignete Antwort finden. Eine voreilige Reaktion, nur weil ein Schiedsspruch einer Vertragspartei, die das Schiedsgericht selbst angerufen habe, nicht gefalle, sei nicht nötig. Dies diskreditiere die gesamte Vergütungssystematik in der Selbstverwaltung und sende ein fatales Signal, da alle Leistungserbringer dieses Gespräch verfolgten. Er versichere jedoch, der GKV-Spitzenverband werde bei einem tatsächlichen Versorgungsproblem nicht tatenlos zuzusehen, auch wenn ein solches aktuell nicht gesehen werde.

Abg. **Dr. Lina Seitzl** (SPD) möchte wissen, wie die einzurichtende Arbeitsgruppe konkret ausgestaltet werde und wie die Debatte um die Vergütung behandelt werden solle.



Nur zur dienstlichen Verwendung

Felix Engelhard (GKV-Spitzenverband) führt aus, der GKV-Spitzenverband sei Mitte Mai auf die Hebammenverbände zugegangen, um Terminvorschläge für die Arbeitsgruppe zu vereinbaren. Diese werde sich am 9. Juli 2025 konstituieren und habe zwei Arbeitsaufträge: einerseits die Begleitung der Vertragsumsetzung zum Ausräumen von Unsicherheiten und zur Unterstützung der Hebammen, beispielsweise bei der Entwicklung von Konzepten zur Reduzierung von Leerlaufzeiten bei Beleghebammenteams, und andererseits die Evaluation. Hinsichtlich der konkreten Ausgestaltung der Evaluation, insbesondere der heranzuziehenden Daten, hätten sich die Vertragspartner jedoch noch nicht ausgetauscht, da der DHV in den Verhandlungen die Heranziehung von Abrechnungsdaten zuvor verweigert habe.

Abg. **Dr. Lina Seitzl** (SPD) fragt, wie der DHV sich die Arbeitsgruppe vorstelle.

Ulrike Geppert-Orthofer (Präsidentin des Deutschen Hebammenverbands (DHV)) gibt an, der DHV habe ein großes Interesse daran, dass die Arbeitsgruppe nicht retrospektiv evaluiere. Stattdessen sollten die bereits vorliegenden Abrechnungsdaten zur Arbeitsweise genutzt werden. Vorgeschlagen werde seitens des DHV, über eine neutrale Institution mit Unterstützung des BMG eine neutrale gesundheitsökonomische Einschätzung zu den Auswirkungen zu bekommen und gegebenenfalls entsprechend nachzujustieren. Es gehe nicht nur um eine Umverteilung, sondern darum, dass sich die Grundlohnsummensteigerung auch in der Vergütung der Hebammen widerspiegele. Dafür müsse der retrospektive Blick in einen prospektiven Blick umgewandelt werden. Wenn die Arbeitsgruppe sich am 9. Juli 2025 konstituiere und sofort mit der Arbeit beginne, könne bis Ende Juli oder Anfang August mit Ergebnissen gerechnet werden.

Abg. **Dr. Kirsten Kappert-Gonthor** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) stellt fest, dass niemand ein Interesse an einer Reduktion oder Verschlechterung der geburtshilflichen Versorgung habe. Die zentrale Frage sei, wie einer zu befürchtenden Verschlechterung entgegengewirkt werden könne. Obwohl der Hebammenhilfvertrag viele Verbesserungen im Bereich der Geburtshilfe enthalte, drohten gerade den Beleghebammen Verschlechterungen, die dazu führen könnten, dass Beleghebammen aus der Versorgung verloren gingen. Dies müsse verhindert werden. Sie richtet ihre Frage an Ulrike

Geppert-Orthofer und möchte wissen, wie die Verbände, die bei der Schiedsstelle gesprochen hätten, organisiert seien, wer wie viele Hebammen vertrete und welcher Verband die meisten Beleghebammen vertrete.

Ulrike Geppert-Orthofer (Präsidentin des Deutschen Hebammenverbands (DHV)) antwortet, der DHV vertrete etwa 95 Prozent der Hebammen, die über einen Berufsverband vertreten würden.

Abg. **Dr. Kirsten Kappert-Gonthor** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) fragt nach einer konkreten Größenordnung.

Ulrike Geppert-Orthofer (Präsidentin des Deutschen Hebammenverbands (DHV)) gibt an, von 18 800 gemeldeten Hebammen auf der Vertragspartnerliste melde der DHV 15 300.

Abg. **Dr. Kirsten Kappert-Gonthor** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) erkundigt sich nach Vorschlägen in den weiteren Verhandlungen, die Entscheidungsprozesse so zu entwickeln, dass die Stimme der Beleghebammen besser gehört werde.

Ulrike Geppert-Orthofer (Präsidentin des Deutschen Hebammenverbands (DHV)) führt aus, Vertragsverhandlungen funktionierten am besten, wenn sowohl für die Leistungserbringer- als auch für die Leistungsträgerseite die gleichen Voraussetzungen gälten und sich beide Seiten gleichwertig gegenüberstünden. Die einfachste Lösung wäre, wenn auch auf Leistungserbringerseite nur eine Unterschrift unter dem Vertrag erfolge. Im Schiedsverfahren müsse der jeweilige Organisationsgrad berücksichtigt werden.

Abg. **Dr. Kirsten Kappert-Gonthor** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) richtet ihre nächste Frage an den GKV-Spitzenverband und bezieht sich auf die Befürchtungen der Beleghebammen, kündigen zu müssen und in die außerklinische Arbeit zu wechseln. Die Evaluation käme dann zu spät. Sie fragt, was der GKV-Spitzenverband von dem Vorschlag halte, eine Modulation anhand der Versorgungs- und Abrechnungsdaten mit dem aktuell in Rede stehende Vergütungssystem vorzunehmen. Damit sei die Entwicklung der Vergütung ersichtlich.

Steffen Waiß (GKV-Spitzenverband) sagt, der Vorschlag für eine erneute Evaluation sei aus mehreren Gründen problematisch. Zuvor seien vier Jahre lang Verhandlung geführt und die Zahlen eingefordert worden. Der DHV habe daraufhin die



Nur zur dienstlichen Verwendung

Verhandlungen verlassen und die Schiedsstelle angerufen, woraufhin diese eine Entscheidung getroffen habe. Er betont, dass gehandelt würde, wenn gravierende Veränderungen festgestellt würden. Die derzeit im Raum stehende Annahme, dass sich etwas verändere, sei jedoch nicht durch Fakten erhärtet. Der GKV-Spitzenverband habe das Selbstbewusstsein, die Versorgung in Deutschland im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben selbst organisieren zu können. Die genannte Vergütung sei ausreichend. Es sei nicht möglich, einen Schiedsspruch des höchsten Gremiums einfach aufzuheben und neu zu verhandeln. Es gebe zudem keine Beobachtungen von Abgängen der Beleghebammen.

Abg. **Dr. Kirsten Kappert-Gonthier** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) wendet sich an den DHV und möchte wissen, für wie ernst die Ankündigungen gehalten würden, dass größere Hebammengruppen der Versorgung verloren gingen und welches Signal es zur Verhinderung brauche.

Ulrike Geppert-Orthofer (Präsidentin des Deutschen Hebammenverbands (DHV)) hält das Szenario für sehr realistisch. Sie erinnert daran, dass die Beleghebammen im Jahr 2017 durch die Umwandlung in Abrechnungsbeschränkungen mit „Null auf Null“ gestartet seien und seit zehn Jahren keine Vergütungserhöhung erhalten hätten. Dies werde mit großer Sorge betrachtet, da die Beleghebammen so nicht weiterarbeiten könnten. Es sei nun ein Signal erforderlich, das von der retrospektiven Evaluation wegführe. Stattdessen sollten die aktuellen Daten herangezogen und angewendet werden. Wenn sich dabei herausstelle, dass die Hebammen so viel verdienten, wie der GKV-Spitzenverband annehme, müsste dieser dem zustimmen können. Die Daten des DHV zeigten jedoch, dass die Hebammen 20 bis 30 Prozent weniger verdienten, was nicht hinnehmbar sei.

Abg. **Julia-Christina Stange** (Die Linke) äußert, das Fachgespräch habe den Sinn, sich eine Meinung zu dem Schiedsspruch zu bilden. Es werde daher keine Seite angegriffen, vielmehr finde sie es gut, dass die Praxis nun angehört werde. Sie möchte wissen, ob das vom GKV-Spitzenverband vorgerechnete Gehalt von 8 000 Euro nachvollziehbar sei.

Dr. Christine Bruhn (Vorstandsmitglied des Netzwerks der Geburtshäuser) antwortet, dieses sei im Prinzip von der Gesamtstruktur her

nachvollziehbar, löse jedoch nicht das Problem.

Ulrike Geppert-Orthofer (Präsidentin des Deutschen Hebammenverbands (DHV)) äußert, es könnten nicht einzelne Punkte herausgegriffen werden, um diese dann auf 8 000 Euro hochzurechnen. Es handele sich immer um eine Mischkalkulation und nach der Berechnung des DHV käme ein Minus von 15 bis 30 Prozent raus.

Abg. **Julia-Christina Stange** (Die Linke) begrüßt die Förderung der Eins-zu-eins-Betreuung, da sowohl Frau als auch Kind davon profitierten. Sie fragt, ob die Berechnung des GKV-Spitzenverbandes der Realität entspreche und ob diese mit der Praxis vereinbar sei.

Ulrike Geppert-Orthofer (Präsidentin des Deutschen Hebammenverbands (DHV)) bezieht sich auf den Bonus für Hebammen, der bei einer Eins-zu-eins-Betreuung zwei Stunden vor und nach der Geburt gezahlt werde. Die Hebammen erhielten dabei zuerst 20 Prozent Abschlag und bekämen anschließend noch etwas dazu, allerdings sei dies sehr streng gefasst. Das Geld bekämen sie nur, wenn kein Notfall eintrete – auch wenn sofort für Ersatz gesorgt werde – und die komplette Zeit in die Eins-zu-eins-Betreuung fließe. Bei schnellen Geburten, die weniger als zwei Stunden dauerten, werde die Eins-zu-eins-Betreuung daher nicht ausbezahlt, ebenso wenig bei einem Schicht- oder Hebammenwechsel oder bei Fehlgeburten. Dies sei eine für die Praxis untaugliche Regelung.

Dr. Christine Bruhn (Vorstandsmitglied des Netzwerks der Geburtshäuser) ergänzt, dass die von Ulrike Geppert-Orthofer beschriebene Praxis in verschiedenen Krankenhausbereichen, etwa Level-I- und Level-IV-Krankenhäusern, auch unterschiedlich stark umgesetzt werden könne.

Abg. **Julia-Christina Stange** (Die Linke) erkundigt sich, ob man sich vorstellen könne, dass die Regelung des § 134a SGB V dafür Sorge, dass sämtliche Hebammen zukünftig ordentlich und mehrheitlich vertreten würden.

Dr. Christine Bruhn (Vorstandsmitglied des Netzwerks der Geburtshäuser) antwortet, im Bereich des § 134a SGB V gebe es verschiedene Verbände, beispielsweise Berufsverbände der Hebammen und Verbände der von Hebammen geleiteten Einrichtungen. Die Bandbreite sei sehr groß, sodass die Vertretung nur durch einen einzelnen



Nur zur dienstlichen Verwendung

Gesamtverband sehr schwierig sei. Es müssten Interessen untereinander abgewogen und ein Gesamtsystem geschaffen werden. Dies habe die letzten Jahre am besten funktioniert, indem die Expertise aus allen Feldern gebündelt und abgestimmt worden sei, um dann geschlossen an die Krankenkassen heranzutreten. So bestehe die größte Schlagkraft.

Ulrike Geppert-Orthofer (Präsidentin des Deutschen Hebammenverbands (DHV)) führt aus, eine Änderung des § 134a SGB V sei dringend notwendig. Aktuell habe der DHV, obwohl er 95 Prozent der berufsständisch vertretenen Hebammen vertrete, nur eine von neun Stimmen in der Schiedsstelle. So könne man, wie bereits 2017 und auch diesmal, leicht ausgebootet werden. Es müsse daher eine demokratische Stimmverteilung sichergestellt werden.

Tagesordnungspunkt 4

Fachgespräch zum aktuellen Gutachten des Sachverständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen und in der Pflege: Preise innovativer Arzneimittel in einem lernenden Gesundheitssystem

Selbstbefassung S-21(14)7

Die **Vorsitzende** erklärt, für die Einführung des Gutachtens seien zwei Minuten und für die weiterführenden Erläuterungen insgesamt zehn Minuten vorgesehen. Für die Fragerunde seien sechs Minuten vereinbart. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeitschläge sie eine verkürzte Fragerunde von drei Minuten vor.

Der Ausschuss erklärt sich mit der Verkürzung einverstanden.

Die **Vorsitzende** begrüßt Prof. Dr. Michael Hallek, den Vorsitzenden des Sachverständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen und in der Pflege (SVR) sowie Frau Prof. Dr. Leonie Sundmacher und Prof. Nils Gutacker, PhD, die das Gutachten vorstellen würden. Ebenfalls anwesend sei Frau Prof. Dr. Melanie Messer. Online zugeschaltet seien Frau Prof. Dr. Stefanie Joos, Prof. Dr. Jochen Schmitt und Prof. Dr. Jonas Schreyögg, ebenfalls Mitglieder des Sachverständigenrates.

Prof. Dr. Michael Hallek (Vorsitzender des Sachverständigenrates zur Begutachtung der

Entwicklung im Gesundheitswesen und in der Pflege (SVR)) berichtet, als Onkologe therapiere er mit neuen, innovativen Arzneimitteln, die teilweise sehr hochpreisig seien. Die Arzneimittelausgaben in der Onkologie seien in den letzten Jahren trotz einer geringen Verordnungszahl stark gestiegen. Damit auch künftig Kranke von neuen Medikamenten profitierten, müssten die Preise moderat bleiben. Vor 15 Jahren habe beispielsweise der Durchschnittseinführungspreis für ein neues Arzneimittel ungefähr 1 000 Euro betragen, zuletzt schwankte dieser um 50 000 Euro, was eine enorme Steigerung bedeute. Manche Medikamente kosteten etwa 2 Millionen Euro. Deshalb habe man untersucht, wie man die Preisfindung für neue Medikamente evidenzbasiert gestalten könnte, ohne dabei Standortnachteile für die pharmazeutische Industrie zu generieren. Vielmehr solle mit einer professionellen und gerechten Preisfindung die Patientenversorgung gesichert werden.

Prof. Nils Gutacker, PhD (Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen und in der Pflege (SVR)) weist auf die Ausgabenentwicklung für Arzneimittel in der GKV hin. Damit auch in Zukunft neue, innovative Arzneimittel in die Regelversorgung gebracht werden könnten, müsse die Preisbildung auf eine stabilere Basis gestellt werden. Bei zu hohen Preisen für neue Arzneimittel fehle das Geld zur Finanzierung echter Innovationen. Für das Jahresgutachten haben man eine Reihe von Instrumenten erarbeitet, um genau an diesem Punkt anzusetzen. Er beschränke sich bei seinen Erläuterungen auf die drei wichtigsten Kernempfehlungen. Die erste sei die Einführung eines globalen Arzneimittelbudgets, um dem Risiko einer unkontrollierten Ausgabenentwicklung entgegenzuwirken. Ein an die Entwicklung der Einnahmenseite gekoppeltes Budget gebe es bereits in Frankreich und Großbritannien, aber auch in anderen Ländern. Daher habe man diesbezüglich Erfahrungswerte. Bei der Überschreitung einer im Budget definierten Ausgabenobergrenze würden rückwirkende Preisabschläge fällig, die alle Hersteller je nach Marktanteil betreffen würden. Als Basis könnten die jährlichen Berechnungen des GKV-Schätzerkreises genutzt werden. Die Budgetierung sei eine Art Sicherheitsventil. Die Ausgaben würden für die Kassen berechenbarer, es würde aber nur dann greifen, wenn das System unter zu hohen Druck gerate. Die Budgetierung sei eines der effektivsten Mittel, um die Ausgabenentwicklung im



Nur zur dienstlichen Verwendung

Arzneimittelbereich einzudämmen und um Mittel für die Förderung von echten Innovationen freizumachen. Die zweite Kernempfehlung beziehe sich auf die Preisverhandlungen zwischen Kassen und Herstellern. In Deutschland habe man, verglichen mit anderen Staaten, die sehr ungewöhnliche Situation, dass die Hersteller den Erstattungspreis eines neuen Medikaments in den ersten sechs Monaten frei festlegen könnten. Der Vorteil dieses Systems sei der schnelle Marktzugang, nachteilig dagegen, dass diese frei festgelegten Preise ein schwieriger Ausgangspunkt für die Verhandlungen seien. Bei bestimmten Indikationen könne es zudem sein, dass innerhalb dieser ersten sechs Monate Patienten bereits mit einem Arzneimittel therapiert worden seien, dessen Zusatznutzen noch nicht belegt sei. Der SVR schlage daher vor, die Systematik umzudrehen, also so lange nur die Kosten der Vergleichstherapie zu bezahlen, bis die Kassen den Aufschlag für den Zusatznutzen mit dem Hersteller verhandelt hätten. Das wäre konsistent mit den Regelungen des AMNOG (Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz) und dementsprechend konzeptionell gut umsetzbar. Die dritte Kernempfehlung sei das lernende Gesundheitssystem. Neue Erkenntnisse über den Nutzen eines Arzneimittels nach dessen Markteinführung oder in der klinischen Praxis sollten systematisch gesammelt und für Preisnachverhandlungen genutzt werden. Dies sei bereits heute möglich, werde aber nicht immer gemacht, und wenn doch, dann oftmals auf Drängen der Hersteller. Die Solidargemeinschaft müsse stärker als aktiver Einkäufer auftreten, um dem Kostendruck entgegenzuwirken. Dazu gehöre auch die Prüfung, ob der Preis eines Arzneimittels nach einigen Jahren noch gerechtfertigt sei. Hierzu bedürfe es einer besseren Dateninfrastruktur, besserer klinischer Register und auch industrieunabhängiger Studien, die durch den G-BA finanziert werden könnten.

Prof. Dr. Leonie Sundmacher (Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen und in der Pflege (SVR)) ergänzt, der SVR habe auch untersucht, wie die Preisbildung mit einer effektiven Standortförderung im Zusammenhang stehe. Er habe daher geprüft, ob ein hohes Arzneimittelpreisniveau zu einer größeren Industrieansiedlung führe, da dies ein häufig bemühtes Argument sei. Dazu habe man internationale Daten untersucht, allerdings keine für diese Behauptung überzeugende Evidenz gefunden. Das sei logisch, da Pharmaunternehmen international agierten und

nicht zwingend die Nähe zum Absatzmarkt benötigten. Die Förderung der pharmazeutischen Industrie sei richtig, dürfe aber nur mit wirtschaftspolitischen Instrumenten erfolgen. Die Verbindung von Preisregulierung auf der einen Seite und Standortförderung auf der anderen halte man für nicht zielführend. Dieser Trend oder diese Verquickung sei seit Inkrafttreten des Medizinforschungsgesetzes erkennbar. So seien beispielsweise Unternehmen, die Probanden aus Deutschland in ihre Zulassungsstudien einschlossen, befristet von den AMNOG-Leitplanken – der Kopplung von Zusatznutzen und Erstattungsbetrag – ausgenommen. Der SVR erkenne die Bedeutung der Pharmaindustrie für den Wirtschaftsstandort Deutschland an und spreche sich für eine gezielte Förderung aus. Er habe daher untersucht, nach welchen Kriterien eine Investitionsentscheidung oder eine Standortwahl getroffen werde. Beides orientiere sich an der Wertschöpfungskette. Betrachte man den Bereich Forschung und Entwicklung, in dem Deutschland stark sei, dann zählten zur Qualität des Forschungsstandorts exzellent ausgebildete Wissenschaftler, regionale Hubs, Verfügbarkeit qualifizierter Fachkräfte oder öffentliche Förderung. Bei diesen Faktoren sei Deutschland gut aufgestellt. Mitentscheidend sei aber auch die Möglichkeit, klinische Studien schnell und effizient durchführen zu können. Hier weist Deutschland Defizite auf. Daher empfehle der SVR dringend, den Schwerpunkt auf den Ausbau der digitalen Forschungsdateninfrastruktur zu legen, diese maßgeblich aus öffentlicher Hand zu finanzieren und unnötige Bürokratie abzubauen. Ein Ausbau der Forschungsdateninfrastruktur komme nicht nur der pharmazeutischen Industrie und der Forschung zugute, sondern nütze auch der Allgemeinheit. Gegebenenfalls könnten Gebühren von den pharmazeutischen Unternehmen erhoben werden, wenn sie die Daten nutzten. Bei der Forschungsdateninfrastruktur komme den Registern eine bedeutende Rolle zu. Dänemark habe nahezu die gesamte Bevölkerung in Registern erfasst und diese miteinander verknüpft. Das sei ein Vorbild, wolle man eine effektive Forschungsdateninfrastruktur entwickeln. Dänemark führe pro Kopf die meisten klinischen Studien durch. Daher laute die Empfehlung, die Register zu verknüpfen und die Datensilos abzubauen, damit randomisierte kontrollierte Studien (RCTs, Randomised Controlled Trials) oder Reevaluationen möglich seien. Grundsätzlich müsse Deutschland bei der



Nur zur dienstlichen Verwendung

Digitalisierung aufholen. Länder wie Dänemark, Frankreich oder Österreich hätten einen höheren Digitalisierungsgrad und eine vorbildliche Infrastruktur. Eine weitere wichtige Maßnahme sei außerdem eine zentrale Anlaufstelle für die Organisation klinischer Studien.

Abg. **Sebastian Schmidt** (CDU/CSU) erkundigt sich, ob sich Deutschland nach der Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen im internationalen Vergleich als Pharmastandort werde behaupten können.

Prof. Dr. Michael Hallek (Vorsitzender des Sachverständigenrats zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen und in der Pflege (SVR)) verweist auf die Ausführungen von Prof. Dr. Sundmacher und ergänzt, es müsse alles unternommen werden, damit Studien schneller durchgeführt werden könnten. Deutschland sei viel zu langsam. Es dauere teilweise bis zu zwei Jahren, bis eine Studie aktiviert sei. Bis dahin sei die Studie international abgeschlossen. Das gelte selbst dann, wenn die Studie in Deutschland initiiert worden sei. Spanien habe beispielsweise in einer konzertierten Aktion eine zentrale Einrichtung zur ethischen Bewertung von Studien geschaffen. Ein weiterer Punkt sei die Förderung von Studien. Dazu benötige es entsprechende Elemente im Bereich der Wirtschaftsförderung oder Venture-Capital, da Studien teilweise Millionen Euro kosteten. Diese Gelder müssten so kapitalisiert werden, dass junge Gründer klinische Studien durchführen könnten und die Wertschöpfung in Deutschland bliebe. Deutsche Erfindungen kämen oftmals als Reimport aus den USA. Dieser Kreislauf müsse durchbrochen werden. Am wichtigsten sei allerdings, die „Entstaubung“ der bürokratischen Regeln und eine zentrale Anlaufstelle. Dann könne Deutschland auch weiterhin ein Standort für Spitzenforschung bleiben.

Abg. **Sebastian Schmidt** (CDU/CSU) erkundigt sich bei Prof. Dr. Sundmacher über die Gesundheitsdateninfrastruktur und welche Maßnahmen erforderlich seien, um beispielsweise Arzneimittel besser bewerten zu können.

Prof. Dr. Leonie Sundmacher (Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen und in der Pflege (SVR)) erklärt, die Möglichkeiten für registerbasierte RCTs seien vielversprechend. Patienten könnten schnell eingeschlossen werden, da die Register bereits existierten.

Während der Pandemie sei Großbritannien ein Vorreiter auf diesem Feld gewesen. Das bedeute für Deutschland, Registerdaten müssten verknüpft zur Verfügung gestellt werden. Zudem werde der Zugang zu den Versorgungsdaten der GKV benötigt. Diese stünden in der ersten Phase nach der Markteinführung noch nicht zur Verfügung, wären aber dann nützlich, wenn ein Medikament beispielsweise reevaluiert werde. Die Versorgungsdaten seien auch zur Förderung weiterer Innovationen wichtig. In Dänemark und Frankreich werde dies konsequent umgesetzt, indem sich jeweils eine Agentur um die Förderung der Pharmaindustrien entlang der Wertschöpfungskette bemühe. Die Agenturen analysierten, wo Defizite bestünden und wie diese beseitigt werden könnten. Es gehe also nicht nur um die Förderung von Forschung und Entwicklung, sondern auch um die Förderung der Produktion innovativer Arzneimittel.

Abg. **Kay-Uwe Ziegler** (AfD) fragt, ob in dem Gutachten auch die Interessen der Patienten eine Rolle gespielt hätten.

Prof. Nils Gutacker, PhD (Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen und in der Pflege (SVR)) antwortet, diese hätten im Zentrum gestanden. Ohne finanzielle Mittel könnten die echten Innovationen nicht finanziert werden. Das wirke sich negativ auf die Patienten aus.

Abg. **Kay-Uwe Ziegler** (AfD) fasst zusammen, die Erstattungspreise könnten für ein halbes Jahr frei von der Pharmaindustrie festgelegt werden. Erst danach gebe es Nachverhandlungen. Er fragt, ob der SVR untersucht habe, wie sich die Preise nach den Nachverhandlungen im Verhältnis zu den ersten Preisen entwickelt hätten und in welcher Größenordnung diese gesunken seien.

Prof. Nils Gutacker, PhD (Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen und in der Pflege (SVR)) bestätigt, dass der SVR die Zahlen ausgewertet habe. Grob geschätzt seien die Preise um etwa 30 Prozent gegenüber dem initialen Listenpreis gesunken.

Abg. **Kay-Uwe Ziegler** (AfD) will weiterhin wissen, ob die Pharmaindustrie diesen kalkulierten Abschlag von 30 Prozent vorab einpreise und wie dies gegebenenfalls ausgeschlossen werden könne. Dazu müssten die Kosten für Forschung und Produktion bekannt sein.



Nur zur dienstlichen Verwendung

Prof. Nils Gutacker, PhD (Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen und in der Pflege (SVR)) bestätigt, der SVR vermute – dies sei empirisch allerdings nicht nachweisbar –, dass in den Initialpreisen der erwartende Abschlag bereits eingepreist sei. Denn dies sei das strategisch richtige Handeln eines pharmazeutischen Unternehmens. Ein guter Preis für ein neues Medikament würde auf den Preis eines sich bereits auf dem Markt befindlichen Medikaments aufbauen und den Zusatznutzen widerspiegeln. Das sei somit kein Abschlagssystem, sondern ein Aufschlagssystem orientiert am Zusatznutzen. Damit habe man auch die Bindung an den Patientenzusatznutzen hergestellt.

Abg. **Kay-Uwe Ziegler** (AfD) erkundigt sich, inwieweit sich bei einem neuen Arzneimittel der Patientennutzen überprüfen und eine Liste der schwarzen Schafe generieren lasse.

Prof. Nils Gutacker, PhD (Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen und in der Pflege (SVR)) antwortet, das Bild sei sehr differenziert, was an der Schwäche des jetzigen Verfahrens liege. Es gebe neue Medikamente, die einen hohen Zusatznutzen hätten, aber auch solche, die im Verlauf der Erprobung keinen Zusatznutzen zeigten oder nur einen viel kleineren und bei bestimmten Patientengruppen gar keinen. In diesen Fällen habe die Solidargemeinschaft nur eine geringe Möglichkeit, die Preise neu zu verhandeln.

Abg. **Matthias David Mieves** (SPD) fragt Prof. Gutacker, PhD nach dem globalen Arzneimittelbudget und den positiven, aber auch negativen Erfahrungen anderer Länder. Zu den Preisverhandlungen der Kassen mit den Herstellern will er wissen, ob, wenn in den ersten Monaten nur der Preis der Vergleichstherapie gezahlt werde, das Risiko bestehe, dass Medikamente in Deutschland später auf den Markt kämen, weil die Pharmaindustrie einen niedrigen Referenzpreis verhindern wolle. Er bittet um eine Bewertung auch hinsichtlich der Minimierung dieses Risikos.

Prof. Nils Gutacker, PhD (Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen und in der Pflege (SVR)) verweist auf die Schwierigkeit eines empirischen Vergleichs, da neben den Budgets weitere Instrumente genutzt würden, was eine Differenzierung erschwere. In

Großbritannien werde teilweise kritisiert, dass Medikamente nicht im gleichen Umfang wie in Deutschland auf den Markt kämen. Großbritannien nutze aber zusätzlich eine Kosten-Nutzwert-Rechnung, die die Überlegung, was sich die Gesellschaft leisten könne, abbilde. Seiner Auffassung nach führe ein Budget nicht dazu, dass Medikamente vom Markt genommen würden, da es erst nach Überschreitung des Budgets rückwirkend Preisschläge gebe. Das bedeute, solange sich die Ausgaben wie erwartet entwickelten, werde die Begrenzung durch das Budget nicht greifen. Es sei eine Art Sicherheitsventil. Zur Frage nach der initialen Bepreisung auf dem Niveau der zweckmäßigen Vergleichstherapie (zVT) und des Markteintritts berichtet er, im Gutachten werde eine andere Umsetzung vorgeschlagen. Zunächst werde weiterhin der Listenpreis ausgewiesen, der aber einen geheimen Abschlag für die ersten sechs Monate enthalte. Dadurch sei der zVT-Preis unbekannt. Referenziere ein Land auf einen Preis, der nur für ein paar Monate gelte, dann habe dieses Land seiner Meinung nach selbst interne Probleme. Hier sei die Kurzfristigkeit ein hilfreicher Faktor. Dadurch, dass man den Zusatznutzen und nicht einen Abschlag bepreise, werde das System auf die richtige Basis gestellt.

Abg. **Matthias David Mieves** (SPD) sagt, der SVR schlage vor, den fiktiven Zusatznutzen abzuschaffen und stattdessen bei der Preisbildung ein zusätzliches Preiskriterium einzuführen. Er erkundigt sich, wie dieses ausgestaltet werden sollte und wie sich dies auf Orphan Drugs auswirke.

Prof. Nils Gutacker, PhD (Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen und in der Pflege (SVR)) antwortet, bei Anhörungen und durch wissenschaftliche Evidenz sei klar geworden, dass es durchaus möglich sei, für Orphan Drugs klinische oder vergleichende klinische Studien durchzuführen. Die Idee, dass der Zusatznutzen nicht nachgewiesen werden müsse, sondern fiktiv angenommen werde, sei nicht hilfreich und führe dazu, dass nicht geforscht werde. Wie man den Aufschlag ausgestalte, sei Aufgabe der Politik und nicht der Wissenschaft. Es gebe aber Beispiele aus anderen Ländern. Japan gewähre beispielsweise einen prozentualen und begrenzten Aufschlag, wenn es sich um Orphan Drugs handele. Dessen Höhe könne er nicht beziffern.



Nur zur dienstlichen Verwendung

Abg. **Dr. Janosch Dahmen** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) fasst zusammen, dass ein geheimer Arzneimittelpreis sowohl standort- als auch versorgungspolitisch möglicherweise nicht von Vorteil sei. Deutschland sei eines der wenigen Ländern mit einem für die meisten Medikamente offenen Arzneimittelpreis. Diese Regelung laufe nun aus. Er fragt, ob der SVR eine andere Form eines geheimen Arzneimittelpreises oder offene Preise befürworte.

Prof. Dr. Leonie Sundmacher (Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen und in der Pflege (SVR)) berichtet, der SVR habe intensiv diskutiert, ob geheime Arzneimittelpreise zum Vor- oder Nachteil der GKV und der Solidargemeinschaft gereichten. Der SVR befürworte einen Interimspreis. Der Hersteller sollte einen Initialpreis wählen, auf den ein Rabatt fällig werde. Insofern wäre der Preis geheim. Von dieser Vertraulichkeit würde Deutschland profitieren. Es wäre ein Instrument, mit dem man sehr gut arbeiten könnte, um einerseits einen öffentlichen Preis zu haben. Andererseits könnte sich der Erstattungsbeitrag nicht mehr so stark am Initialpreis orientieren.

Abg. **Dr. Janosch Dahmen** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) erkundigt sich bei Prof. Dr. Hallek, wie ein jährliches Ausgabenbudget für hochpreisige Arzneimittel so gestaltet werden könne, dass es sowohl eine Planbarkeit für die Hersteller als auch eine nachhaltige Finanzierung im solidarischen Gesundheitssystem gewährleiste.

Prof. Dr. Michael Hallek (Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen und in der Pflege (SVR)) sagt, die beiden zentralen Werkzeuge habe er genannt. Das eine sei das globale Budget, wenn man die Ausgaben nicht mehr finanzieren könnte. Das sei ein sehr kurzfristig wirksames Werkzeug. Das zweite Werkzeug könnte greifen, wenn der häufig beobachtete Fall eintrete, dass das neue Medikament nicht wie erhofft wirke. Als Beispiel nennt er millionenteure Gentherapeutika. Wenn man deren geringe Wirksamkeit sehr schnell feststelle – hierfür würden Daten und Register benötigt –, könnte man zügig in neue Verhandlungen eintreten. Das werde bei den hochpreisigen Medikamenten befürwortet. Pay-for-Performance für teure Einmalausgaben sei ein weiteres, allerdings umständlich zu administrierendes und von den Kassen nicht präferiertes Werkzeug. Daher habe man dies heute nicht in den Vordergrund gestellt. Er weist darauf hin, dass die

vorgestellten Vorschläge nicht alle sofort und gleichzeitig umgesetzt werden sollten und könnten. Sie seien vielmehr als Werkzeug im Werkzeugkasten zu verstehen. Einige Instrumente wie das globale Budget wirkten sehr pauschal und kurzfristig, andere wirkten gezielter.

Abg. **Ates Gürpınar** (Die Linke) sagt, Frankreich und Großbritannien seien als positive Beispiele für die Budgetierung genannt worden. Er erkundigt sich, ob es noch weitere Länder gebe, die als Vorbild dienen könnten.

Prof. Dr. Leonie Sundmacher (Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen und in der Pflege (SVR)) erklärt, es sei immer hilfreich, ähnliche Gesundheitssysteme zu betrachten. Frankreich sei ein gutes Beispiel, da es dort ein Sozialversicherungssystem gebe und man ähnlich wie in Deutschland mit sehr hohen Arzneimittelausgaben kämpfe. Frankreich habe diesen Ausgabenanstieg gut gedrosselt, auch durch die Einführung des Globalbudgets im Jahre 1999. Das Globalbudget fokussiere die Finanzierung, bewerte aber nicht die Nützlichkeit eines Medikaments. Deutschland habe die absolute Besonderheit, dass nach der Markteinführung jeder Preis erstattet werde. Das sei in Frankreich nicht der Fall. Dort habe man eine Positivliste, wie die meisten anderen Länder auch. Die zweite deutsche Besonderheit sei, dass der Preis für ein neues Medikament für die ersten sechs Monate vom Pharmaunternehmen frei festgelegt werden könne. Dagegen beobachte Frankreich zunächst den Nutzen. Medikamente ohne Nutzen würden nicht erstattet. Damit sei nicht der Zusatznutzen, sondern die wirkliche Nützlichkeit gemeint.

Abg. **Ates Gürpınar** (Die Linke) erklärt, bereits früher sei der Versuch unternommen worden, den Preis auf Grundlage des Zusatznutzens mathematisch und mit Effizienzgrenzen zu bestimmen. Er fragt, wie der SVR diesen Ansatz bewerte und ob die Budgetierung ein Zwischenschritt sein könnte, mittels dem der Preis noch enger an den Nutzen oder Zusatznutzen gebunden werden könnte.

Prof. Dr. Michael Hallek (Vorsitzender des Sachverständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen und in der Pflege (SVR)) berichtet, der SVR habe angeregt, darüber nachzudenken, die Budgetierung um eine Kosten-Nutzwert-Analyse zu ergänzen, also neue



Nur zur dienstlichen Verwendung

Arzneimittel anhand von patientenrelevanten Endpunkten oder ähnlichem zu bewerten. Das sei zwar schwierig, trotzdem werde man darüber diskutieren müssen, um eine etwas stringenter Bewertung neuer Substanzen oder Arzneimitteln zu erhalten. Diese Diskussion werde in anderen Staaten bereits geführt, in Deutschland sei sie überfällig.

Prof. Nils Gutacker, PhD (Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen und in der Pflege (SVR)) ergänzt, das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen habe damals vorgeschlagen, Effizienzgrenzen zu nutzen. Dies sei in der wissenschaftlichen Literatur als kritisch angesehen worden, weil für jede Indikation ein anderer Effizienzgrad gegolten hätte oder ein Preis hätte festgelegt werden müssen. Damit wäre man eng an frühere Entscheidungen hinsichtlich einer Indikation gebunden gewesen. Für Patienten mit einer anderen Krankheit, die das gleiche Medikament benötigten, hätten gegebenenfalls andere Preise gegolten, was als nicht sinnvoll und fair erschienen sei. Daher sei das Instrument damals abgelehnt worden. Die richtige Idee wäre eine Kosten-Nutzwert-Analyse mit einem einheitlichen Maßstab für den Nutzen.

Die **Vorsitzende** verabschiedet die Sachverständigen und schließt den Tagesordnungspunkt.

Antrag zur Geschäftsordnung

Abg. **Julia-Christina Stange** (Die Linke) meldet sich zur Geschäftsordnung und erinnert an ihren Antrag auf Durchführung einer Sondersitzung in der Haushaltswoche zu dem sogenannten Maskendeal, den sie bei den Obleuten formuliert habe.

Die **Vorsitzende** erwidert, die Sondersitzung müsse offiziell in der Sitzung beantragt werden, da bei den Obleuten kein Einvernehmen habe hergestellt werden können.

Abg. **Ates Gürpınar** (Die Linke) beantragt für seine Fraktion in der Haushaltswoche eine Sonderausschusssitzung zur Beschaffung von Masken während der Corona-Pandemie, zu der Frau Dr. Sudhof und Abg. Jens Spahn eingeladen werden sollten. Hinsichtlich des genauen Datums könne seine Fraktion einen Vorschlag unterbreiten.

Die **Vorsitzende** erläutert, zur Einberufung einer Sondersitzung werde die Tagesordnung sowie ein

Datum benötigt, damit entweder § 60 Absatz 2 oder Absatz 3 GO-BT angewendet werden könne.

Abg. **Emmi Zeulner** (CDU/CSU) fügt hinzu, die Linke habe zwar in der Obleute-Besprechung angedeutet, dass sie diesen Antrag stellen wolle. Dies hätte aber zu Beginn der Sitzung erfolgen müssen, da viele Kolleginnen und Kollegen gleichzeitig in unterschiedlichen Ausschüssen aktiv seien. Sie bitet, das Thema Antragstellung und Abstimmung in der nächsten Obleute-Besprechung zu thematisieren. Der Bericht zur Maskenbeschaffung sei heute als eigener Tagesordnungspunkt 2c unter Anwesenheit der Ministerin aufgerufen worden. Zudem habe man die Fragerunde von drei auf fünf Minuten erweitert. Weiter gebe es in dieser Woche zwei aktuelle Stunden zum Thema und zudem beschäftige sich der Haushaltsausschuss damit. Das Ziel der Obleute-Besprechung sei, sich im Vorfeld und im Idealfall einvernehmlich zu einigen. Dies könne keine Einbahnstraße sein.

Abg. **Julia-Christina Stange** (Die Linke) bestätigt, dies; sei aber kein Einvernehmen herzustellen, müsse der Ausschuss entscheiden.

Die **Vorsitzende** stellt ein Meinungsbild durch Abstimmung her.

Der Ausschuss lehnt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen AfD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke die Durchführung einer Sondersitzung in der Haushaltswoche ab.

Tagesordnungspunkt 5

Unterrichtung durch die Bundesregierung

Bericht des GKV-Spitzenverbandes über die Inanspruchnahme und Entwicklung der Versorgung mit Digitalen Gesundheitsanwendungen 2024

BT-Drucksache 21/110

abgesetzt

Die **Vorsitzende** gibt bekannt, dass sie möglicherweise in der Sommerpause, voraussichtlich Ende August, eine Sondersitzung zur Beratung des Haushalts des BMG einberufen werde. Der genaue Termin hänge von den Beratungen des Haushaltsausschusses ab. Die Obleute hätten sich darauf verständigt, dass diese Sitzung rein digital durchgeführt werden solle.



Nur zur dienstlichen Verwendung

Weiter informiert sie, dass die September-Sitzung wahrscheinlich im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus stattfinden werde, da die Technik im Sitzungssaal PLH E 300 erneuert werde.

Schluss der Sitzung: 12:59 Uhr

gez.

Dr. Tanja Machalet, MdB
Vorsitzende